行业 AI 书系 · 55

合规获客

医美口腔机构的 AI 增长与风控手册



摩豆智能　卢章　著

milulab.com/books

合规获客

医美口腔机构的 AI 增长与风控手册

摩豆智能　卢章　著

dearsuley@gmail.com

2026 年 · 初稿（供选题评议用）

目　录

前言 v
这本书写给谁 v
这本书讲什么 v
怎么用这本书 v
关于事实口径 vi
术语表 vi
第 1 章 双面夹击：获客贵与监管严同时到来 1
本章导读 1
1.1 收入端：种植牙价格腰斩之后 1
1.2 成本端：3000 元一个客户的获客账 2
1.3 监管端：50% 抽查是什么概念 2
1.4 四条合规高压线 3
1.5 AI 能帮上的七个位置 4
1.6 这本书的地图：一条增长线，一条合规线 4
第 2 章 先把 AI 用明白：会提问比会工具更重要 8
本章导读 8
2.1 大模型是什么：懂到「会用」就够了 8
2.2 三条边界：幻觉、时效、上下文——医疗场景为什么格外致命 9
2.3 四要素骨架：把机构的活说清楚 9
2.4 机构提示词库：运营、咨询、合规三分区 10
2.5 选工具：通用大模型、诊所 SaaS、GEO 服务商各管什么 11
第 3 章 获客账本与 AI 路线图：3000 元一个人的仗怎么打 14
本章导读 14
3.1 获客成本是怎么花出去的 14
3.2 集采之后，这笔账必须重算 15
3.3 AI 获客的五条路：一张地图 15
3.4 GEO 为什么被叫作「2026 最大红利」 16
3.5 分档起步：单店、连锁、医生工作室各先做什么 17
第 4 章 内容种草：科普与口碑内容的合规批量生产 20
本章导读 20
4.1 选题从患者嘴里来，不从爆款库里抄 20
4.2 AI 初稿：把红线写进提示词，比写完再改省事 21
4.3 医生改稿：三处必须人来改的地方 21
4.4 分平台适配：一条母稿的四种长相 22
4.5 排期与复盘：产能的账在什么参数下成立 22
第 5 章 GEO：让 AI 回答里带着你 25
本章导读 25
5.1 AI 回答里的位置是攒出来的，不是买出来的 25
5.2 AI 回答引用谁：可验证性优先于宣传性 25
5.3 布局三件套：资质、案例、科普，一致性是命门 26

5.4 用 AI 检测你的 AI 可见度 27
5.5 冷水与防坑：甄别服务商的三个问题 27
第 6 章 本地生活与私域：把流量接住养起来 30
本章导读 30
6.1 套餐双层结构：引流款把人带进店，医生把人留下来 30
6.2 医疗类目开店：资质是门票，规则卡是日常 31
6.3 评价运营：邀评靠真实，回差评靠流程 31
6.4 私域分层：能线上说的和必须面诊说的 32
6.5 复购与转介绍：老客的第二次价值 32
第 7 章 咨询与转化：从留资到到店复购 35
本章导读 35
7.1 咨询的第一变量是速度，不是话术 35
7.2 首次响应：自动首响兜底，人工接管收口 36
7.3 面诊前预沟通：收集信息，不给方案 36
7.4 异议处理：回应顾虑，不碰三条红线 37
7.5 术后随访：AI 排程，人做关怀 37
7.6 AI 不接手清单：三样内容必须人定稿 38
第 8 章 医疗广告红线：一张审查证明管住全部内容 40
本章导读 40
8.1 科普还是广告，边界比多数机构想的窄 40
8.2 禁用词四分类：AI 最容易踩的坑，也是最值得流程防的坑 41
8.3 案例与对比照：真实性、授权、个体差异三道关 41
8.4 平台医疗类目规则：共性从严，差异建卡 42
8.5 发布前检查清单：流程防错，不靠自觉 42
第 9 章 药械、集采与追溯：合规的硬底盘 45
本章导读 45
9.1 台账拼的不是态度，是记录能不能当场对上实物 45
9.2 UDI 追溯：一条记录链经得起倒查 46
9.3 集采之后：价格透明化，价值往技术与劳务上落 47
9.4 效期、库存与不良事件监测：省钱的合规 47
9.5 台账工具怎么选：账跟着采购笔数走 47
第 10 章 资质与迎检：50% 抽查怎么应对 50
本章导读 50
10.1 迎检是翻平时的作业本，不是突击战 50
10.2 机构资质与人员资质：逐人核对，不留「大概没问题」 51
10.3 知情同意与病历：告知是医生的事，整理可以是 AI 的事 51
10.4 监管在教什么：五场动作反推检查重点 52
10.5 季度自查节拍：档案五类，AI 归档 52
第 11 章 医生个人 IP：主治医师的安全做号法 55
本章导读 55
11.1 信任前置：IP 改变的是获客成本的结构 55
11.2 定位先选科普型：三栏内容框架，营销有一成上限 56
11.3 AI 流水线：医生的时间压到每条 15-30 分钟 56

11.4 资质展示边界：能写的要有证明，不能写的别碰 57
11.5 平台医生认证：材料一次备齐，名称三处一致 57
11.6 机构号与医生号：一条生产线，两个出口 58
第 12 章 团队、培训与底线：把合规做成竞争力 60
本章导读 60
12.1 岗位不分清楚，AI 产能越大机构越乱 60
12.2 培训记录就是合规资产：把监管的免费课变成机构的台账 61
12.3 数字化人才：缺口 8 万的行价，内培比外招现实 61
12.4 机构级风险检查清单：全书风险收进一张表 62
12.5 长跑：合规是 AI 增长复利的前提 63
附录 65
附录 A 高频提示词索引 65
附录 B 本书出现的工具与平台 65
参考文献与资料来源 66
一、政策与监管文件 66
二、政府采购与监管活动公开信息 67
三、行业资料与报告 67
四、课件与改编素材 68

阅读地图：从哪读到哪

篇	章区间	读什么，怎么用
第一篇 · 认知与基本功	第 1-2 章	看清行业形势与政策口径，练成提示词这项全书通用技能。先读这两章，后面的每个场景都用得上。
第二篇 · 核心场景实操	第 3-10 章	按业务环节逐章给出可复制的提示词与工作流。可以整篇顺读，也可以按手头的活直接翻到对应一章。
第三篇 · 合规、组织与成长	第 11-12 章	数据红线、责任划分与使用边界；再把个人方法放大成团队与机构的能力，规划长期路线。

时间紧的读者：第一篇第 2 章的提示词四要素是全书地基；第二篇按需跳读；第三篇的合规清单建议全书读完后再回看一遍。

前言

这本书写给谁

如果你开着一家医美机构或者口腔诊所，这两年大概有两次深夜算账的经历。

一次是算获客的钱。一个到店客户平均要花三千块才能换回来（行业白皮书口径），而种植牙集采之后，一颗牙的收入从一万五掉到七千。这一头进、那一头出，账越算越薄。

另一次是算合规的心。2026 年的国家随机监督抽查计划把一半的医美机构列进了年度抽查名单，广告、药械、资质、知情同意，条条都在查。地方监管的培训会一个接一个地开，去听了才知道，罚款是真的会落到自己头上的。

这本书就是写给这两次算账的人：机构的老板和运营负责人、市场总监、咨询师团队的管理者。质控和合规岗可以直接把第三部分当工作手册；想安全做自媒体的主治医师，看第十一章；消费医疗 SaaS 和获客服务商的从业者，翻一遍能更懂你的客户在愁什么。

这本书讲什么

一句话：用 AI 把获客做便宜，用流程把合规做扎实。

它不是两本书缝在一起，而是一件事的两面。你在用 AI 批量生产科普内容的时候，每一篇都要过「这句算不算医疗广告」的检查；你在追 GEO 流量红利的时候，挂出去的资质和案例必须是真的、审过的。AI 把产能放大十倍的时候，也把犯错的可能放大了十倍——所以增长和风控必须同册讲，这就是本书的结构：

- **第一部分（第 1-3 章）看局面**：钱怎么变薄的、监管查什么、AI 能帮哪七个位置，再把获客的账算透。
- **第二部分（第 4-7 章）走增长线**：内容种草、GEO、本地生活与私域、咨询转化，四条获客路逐条过。
- **第三部分（第 8-10 章）走合规线**：医疗广告红线、药械集采与追溯、资质与迎检，三道关逐个过。
- **第四部分（第 11-12 章）落到人**：医生个人 IP、团队分工与内部培训，最后合成一张机构级检查清单。

怎么用这本书

手头有什么事，直接翻对应章。每章自包含，不读前面的章也能跟上。

你手头的事	先读
想弄清监管到底查什么、罚款多重	第 1 章，第 10 章
团队刚开始用 AI，不知道边界在哪	第 2 章
获客成本压不下来，想换打法	第 3 章，然后按第 4-7 章逐条试
想批量做科普内容又怕踩广告红线	第 4 章 + 第 8 章（这两章配套用）
听说 GEO 是红利，不知道怎么入手	第 5 章
做了团购和私域，到店率上不来	第 6 章、第 7 章
要准备迎接抽查	第 10 章，第 9 章按需
医生想做号	第 11 章，第 8 章必读
想给团队做内训	第 12 章，各章练习题直接当培训素材

全书有一句统一立场，先放在这里：**AI 管产能和速度，判断与签字始终在人。** 诊疗的判断、效果的承诺、价格的口径、风险的告知，这四样永远不能交给 AI 定稿。每个会写东西的章节里，你都会看到这条纪律的具体样子。

关于事实口径

书中所有行业数据只来自四类来源：公开政策文件（如 2026 年国家随机监督抽查计划、海口合规指导清单）、政府采购与监管部门的公开信息、公开发布的行业报告与白皮书（转述时注明口径）、作者团队真实交付项目的脱敏经验。查证不到的数字一律不写，你读到「待验证」的地方就是诚实的边界。监管条款的执行细则各地有差异，本书给的是全国面上口径，落地前请以当地卫健、市监部门的现行文件为准。

术语表

按出场顺序整理，正文第一次出现时会再解释一遍；拿不准时回这一页查。

术语	一句话解释
消费医疗	指向个人消费选择、非治疗刚需主导的医疗服务，本书主要指医美与口腔
医疗美容（医美）	运用药物、手术、医疗器械等侵入性方式对容貌进行的医疗行为，须持医疗机构执业许可
主诊医师	医美机构对每项诊疗须配置的负责医师，法规对其临床年限与培训有硬性条件
随机监督抽查	监管部门按计划随机抽取检查对象、随机选派执法人员的年度检查制度
医疗广告审查证明	医疗广告发布前须取得的审查文件；无证发布即违法
虚假广告罚则	广告法对虚假医疗广告的处罚，可处广告费三到十倍罚款（海口清单引用口径）
集采（集中带量采购）	医保部门组织的批量采购，以量换价；口腔种植体集采把单颗均价从约 1.5 万元拉到 7000 元
技耗分离	把医疗服务技术收费与医用耗材收费分开计价的改革，种植牙领域已落地

术语	一句话解释
UDI	医疗器械唯一标识，器械全生命周期的「电子身份证」，追溯记录的载体
进货查验	医疗机构购入药械时查验资质与合格证明并记录的法定义务
索证索票	进货时向供应商索取证照票据并留档的做法，与进货查验配套
不良事件监测	对医疗器械使用中可疑伤害事件的收集报告义务
知情同意	诊疗前向患者说明风险并取得书面同意的法定程序
获客成本	换来一个到店客户所花费的平均营销投入，本书引用口径为医美行业突破 3000 元/人
留资	潜在客户在线上留下联系方式的行为，咨询转化流程的起点
到店转化	从留资线索到实际进店的比例，获客漏斗的关键折损点
私域	机构可自主触达的客户资产（微信好友、社群、会员体系）
SCRM	社会化客户关系管理工具，给私域客户打标签、排跟进节奏的系统
内容种草	用科普、口碑类内容影响消费决策的获客方式
GEO	生成式引擎优化，让大模型回答用户提问时提到你的机构
SEO	搜索引擎优化，让机构在搜索结果里排前面，GEO 的前身
本地生活团购	美团、抖音等平台上以套餐形式售卖、到店核销的服务品类
引流款	低价套餐，目的是把人带进店；与之相对的利润款承接真实收入
大模型	能理解和生成自然语言的人工智能系统，本书所有 AI 方法的底层
提示词（Prompt）	你发给 AI 的指令文本，决定它输出的质量
幻觉	AI 一本正经编造不存在事实的现象，医疗场景里是头号风险
知识时效	大模型训练数据有截止日期，新政策新价格它可能不知道
上下文长度	AI 一次能处理的文本量上限，超了就丢信息
智能体（Agent）	在大模型基础上挂上知识库和工具、能执行多步任务的 AI 应用
知识库	喂给 AI 的机构自有资料集合，让它答你机构里的事
医疗广告禁用词	法规与平台禁止在医疗内容里出现的表述，如疗效保证、治愈率承诺

术语	一句话解释
以案释法	监管培训中用真实处罚案例讲解法规的方式，诸暨等地培训会的主打形式
面诊	医生当面评估并给出方案的环节，线上沟通的合规边界线

写这本书时我们反复提醒自己一件事：机构老板不需要再多一本喊口号的书，需要的是能照着做、做完不挨罚的操作手册。所以每一章都配了提示词、清单和练习。至于效果——好用，才算做完。

第 1 章 双面夹击：获客贵与监管严同时到来

本章导读

这一章回答一个前置问题：为什么消费医疗机构的 AI 升级不能再等。答案不靠感觉，靠三组数字：收入端，种植牙集采把单颗均价从约 1.5 万元打到 7000 元，全国近 1.8 万家机构参与、民营占八成——靠高客单躺赚的时代结束了；成本端，医美行业平均获客成本已经突破 3000 元一个人；监管端，2026 年国家随机监督抽查把 50% 的医疗美容机构列进年度抽查名单，广告、药械、资质、知情同意四条线同时查。读完这章，你能看清自己处在什么局面、哪些事躲不掉，以及 AI 在哪些位置真能帮上忙——最后拿到全书地图。

1.1 收入端：种植牙价格腰斩之后

先看最直接的那刀。口腔种植体系统集采落地后，单颗种植牙的均价从约 1.5 万元降到了 7000 元左右。参与这轮集采的机构接近 1.8 万家，其中民营口腔机构约 1.4 万家，占八成——也就是说，集采不是公立医院的事，民营机构才是主力参与者。

几个关键事实摆在一起看：

- 首轮集采价格腰斩，客单价直接掉了一半。
- 2026 年 9 月 28 日，国家医保局（四川牵头）启动接续采购，规则关键词是「稳临床、保质量、反内卷、防围标」，竞价方式改成公开询价。
- 民营口腔机构这次「上桌」了——首次参与集采规则的制定，不再是纯接受方。
- 中选产品纳入省级重点监管目录，UDI（医疗器械唯一标识）全程追溯。

（来源：经济观察报对集采接续采购启动的报道，2026 年 9 月）

这四条放在一起，读出来的信号很清楚：价格不会弹回去，监管反而更细了。种植项目的毛利被压缩，接下来机构能挣的钱，要从运营效率里抠出来——获客成本省一点、复购多做一点、合规罚款一次都别挨。

有人会问：集采是口腔的事，医美呢？医美没有集采，但逻辑是一样的——监管对价格与广告的收紧（下一节和 1.4 节会展开），同样在压缩「粗放营销、高额客单」这条老路的利润。两个细分，同一个方向：靠信息差和营销轰炸挣快钱的时代在结束。

1.2 成本端：3000 元一个客户的获客账

收入降了，成本没降。行业白皮书给出的口径：医美行业平均获客成本已经突破 3000 元/人。

把这个数放进一张简单的账里：一位种植牙客户，集采后客单价 7000 元上下，获客成本 3000 元，还没算人工、耗材、房租——按公开口径粗算，光获客就吃掉客单价的四成多。医美项目的客单价高一些，但 3000 元同样不是小数。这笔账是第 3 章的主角，这里先立一个结论：**获客成本不降下来，机构就是在给平台和渠道打工。**

那 AI 能不能把它降下来？行业里已经有人在降了。现状是工具成熟度远超大多数机构的想象：

- 口腔医美 SaaS 已经内置 AI 能力：领健 e 看牙等产品带 AI 病历、AI 影像分析，ABC 诊所管家也是同类——工具不是要不要用的问题，是你用了没有。
- 医美 GEO（生成式引擎优化）/AI 获客的服务商已经成体系，白皮书甚至把 GEO 称为「2026 最大红利：技术布局后流量免费」。

后一种说法要先打个折。技术布局后流量免费，是布局完成之后的愿景，不是今天按个按钮就有的效果——GEO 要布内容、布结构化信息，见效以周和月计。但它指出的方向是真的：用户已经开始问 AI「这个项目哪家机构好」，AI 的回答里有没有你，正在变成新的获客阵地。怎么布、怎么防坑，第 5 章专门讲。

1.3 监管端：50% 抽查是什么概念

2026 年 3 月 19 日，国家疾控局、国家卫健委、国家中医药局三部门联合印发《2026 年国家随机监督抽查计划》（国疾控综监督二函〔2026〕63 号）。里面有两个数字值得贴在办公室墙上：

- **50% 的医疗美容机构**纳入年度抽查。
- 20% 的内设医美科室的医疗机构纳入抽查。

口腔医疗机构列入医疗卫生抽查对象。

抽查查什么？四样：机构和人员资质、药械管理、医美广告发布、知情同意。

50% 是什么概念？一半的医美机构今年就会被查到。对单家机构来说，年内被抽中的概率是抛硬币——两年内大概率轮到一次。这不是「会不会查到我」的问题，是「什么时候查到我」的问题。

监管的密度在地方上还有更直观的体现。2026 年这一年，各地动作密集：

时间	地方动作	规模
2026-07	诸暨市卫健局、市监局等启动口腔与医美诊疗服务能力提升专项行动，办「五个一」集中培训	78 家机构负责人参加，61 起违法案例以案释法
2026-08	福鼎市行业协会承接行业告诫会加合规培训	51 家机构负责人参会

时间	地方动作	规模
2026-09	汕头市市监局办医美机构医疗器械质量安全法律法规培训会	100 余人
2026-10	潜江市市监局办医美机构约谈暨合规培训会	70 余人
2026-01	深圳宝安区市监局办医美机构合规培训，区妇幼保健院设「医美科普合规基地」	区级指定医院承办

（来源：各地监管部门公开信息，检索日期 2026-11-01）

注意一个细节：这些培训全是**政府组织、免费参加**的。监管在花钱教你合规——潜江那场培训讲的就是进货查验、索证索票、以案释法。免费的课都要密集开，说明检查不是虚张声势。去听课，是成本最低的合规信息来源；把它变成机构内部的培训体系，是第 12 章的话题。

1.4 四条合规高压线

抽查查的四样，落到机构日常，就是四条高压线。每一条都有明确的罚则，我们把口径列清楚。

第一条线：广告。 口径来自海口市营商环境建设局 2026 年 7 月发布的《医疗美容机构、医疗口腔诊所行政合规指导清单》——目前少见的政府发布全维度合规清单。要点：任何形式的医疗广告，包括线上平台、小程序、公众号，发布前须取得《医疗广告审查证明》，未审先发即违法；虚假广告可处广告费 3-10 倍罚款，按海口清单引用的广告法罚则，金额可达 20-100 万。这条线在第 8 章专章展开，因为它和 AI 内容生产直接撞在一起——AI 一天能帮你写二十篇文案，每一篇都可能是一张罚单，也可能都过了审查。

第二条线：药械。 口径来自《医疗器械监督管理条例》（2024 修订）：罚则最高 5-20 倍货值罚款。合规动作是购、验、存、用全链条自查加追溯记录（UDI）。种植体集采的中选产品又纳入了省级重点监管目录——口腔机构注意，你用得最多的耗材恰好是监管盯得最紧的耗材。第 9 章讲数字化台账怎么做。

第三条线：人员资质。 还是海口清单的口径：医美主诊医师有硬条件——美容外科 6 年、美容牙科 5 年相关临床经历，加培训合格。这不是内部约定，是法定条件；机构里坐诊的人资质不够，查到就是机构的责任。第 10 章自查清单里有专门一项。

第四条线：财税。 2026 年 1 月 1 日《增值税法》施行，民营口腔的财税合规进入强制阶段（行业专栏解读口径，具体条文以法规原文为准，待验证）。这条线本书不展开方法，只把它放进检查清单提醒你别漏。

四条线合起来看，有一个共同的形状：**都有明确罚则，都能被抽查覆盖，都要求「日常做记录」。** 合规不是检查前突击能补的东西，进货查验要每笔留痕、广告审查要发布前

拿证、知情同意要术前签字——这些动作的共性是必须在平时做。这也是第三部分三章的共同主张：把合规拆成日常流程，而不是季度恐慌。

1.5 AI 能帮上的七个位置

局面讲完，说说 AI 到底能干什么。把机构的工作拆开，AI 能接手的位置有七个，本书的十二章就挂在这七个位置上：

增长侧四个：

1. **内容生产**——科普文案、种草笔记、短视频脚本，AI 出初稿、医生改定稿（第 4 章）。
2. **GEO 布局**——结构化信息的整理、AI 可见度的检测（第 5 章）。
3. **私域与本地生活运营**——团购文案、差评回复初稿、分层跟进话术（第 6 章）。
4. **咨询提效**——留资响应话术、异议处理参考、随访排程（第 7 章）。

合规侧三个：

5. **广告合规流程**——发布前检查清单的初筛、禁用词自查（第 8 章）。
6. **药械台账**——进货查验记录的电子化整理、效期提醒（第 9 章）。
7. **迎检自查**——自查清单生成、培训记录与迎检资料归档（第 10 章）。

但七个位置共享一条纪律，比七个位置本身都重要：**AI 出的东西，必须过人的合规审核才能发出去、用出去。** AI 不知道你的审查证明拿到没有，不知道这句疗效描述踩不踩禁用词，不知道这个价格口径能不能对外说。这些判断在人。医疗场景里，「AI 管产能和速度，判断与签字始终在人」不只是工作方法，是避开罚款的保命条款。

还有一个位置本书没算进七个，但值得你知道：临床本身。AI 病历、AI 影像分析已经进 SaaS 了（领健 e 看牙、ABC 诊所管家的内置能力），但那是医生的事、临床的事，本书定位在运营与合规，不越界去讲诊疗。这条边界，也是医疗行业用 AI 该有的边界。

1.6 这本书的地图：一条增长线，一条合规线

全书 12 章，两条主线拧成一股绳。



图 1-4 全书 12 章双线地图：局面与底盘→增长线→合规线→人与长跑

第一部分（第 1-3 章）局面与底盘。 你已经在读的第 1 章是局面；第 2 章打底 AI 的通用能力——三条边界加提示词，所有章节的 AI 用法都建立在这章之上；第 3 章把获客的账算透，给出五条路和分档起步路线。

第二部分（第 4-7 章）增长线。 四条获客路逐条过：内容种草、GEO、本地生活与私域、咨询转化。每章给「AI 能省在哪」的具体方法，同时预告该配套的合规动作。

第三部分（第 8-10 章）合规线。 三道关逐个过：医疗广告红线、药械集采与追溯、资质与迎检。每章给清单和流程，可直接当内训材料。

第四部分（第 11-12 章）人与长跑。 医生个人 IP 的安全做法；团队分工、内部培训与机构级检查清单。

两条线怎么配合？举一个最常见的例子：市场部用 AI 批量写科普（第 4 章），每篇发出前过一遍第 8 章的发布前检查清单；质控岗每季度用第 10 章的自查清单过一遍全机构；老板每半年把第 3 章的获客账重算一次，决定预算往哪条路加。三个人三本账，合起来才是机构的全貌。

最后交代事实口径，全书统一。书中行业数据与案例只来自三类来源：公开政策文件、政府采购与监管部门公开信息、公开发布的行业报告与白皮书（注明口径），外加作者团队真实交付项目的脱敏经验。监管细则各地有差异，本书给全国面上口径；海口清单是地方样板，你家所在城市怎么执行，以当地文件为准。查证不到的细节，我们一律不写。

动手练习

给 AI 出第一道「合规题」，顺便体验一次「下指令→核验→迭代」的完整循环。步骤：

1. 打开你手机或电脑上任一大模型对话应用（GLM、豆包、DeepSeek、文心一言均可），新建对话。
2. 把下面这条提示词原样发过去：

> **你是一家民营口腔诊所的合规顾问。请按以下五个维度，帮诊所列出一份自查清单：机构资质、人员资质、医疗广告、药械管理、价格公示。每个维度列 3–5 个检查项，每项一句话说明查什么。用表格输出。**

3. 核对它的回答，重点查三处：①「医疗广告」维度里，它有没有提到「发布前须取得医疗广告审查证明」这个关键动作？漏了就是硬伤；②「人员资质」维度，它给的医师资质条件具体吗？拿海口清单的口径对（美容外科 6 年、美容牙科 5 年临床经历加培训合格）；③有没有编造你不认识的法规名称或文号？凡是具体的文号、条款号，都要存疑核实。
4. 追问一轮：「药械管理维度里，UDI 追溯记录具体要记哪些字段？」观察它给的细节是否可信。拿不准的记下来，问当地市监部门或查条例原文。

这个「下指令→核验→迭代」的循环，就是第 2 章要正式教的完整工作方式。练习做完别删对话——下一章开篇还会用到它。

思考题

1. 种植牙集采后单颗均价约 7000 元，按获客成本 3000 元粗算，光获客就占客单价四成多。算上人工耗材房租，你的机构靠什么挣钱？用你机构自己的数字重算一遍这道题。
2. 50% 的医美机构纳入 2026 年度抽查。如果检查组下周就到你机构，四条高压线里你最有把握的是哪条、最没把握的是哪条？没把握的那条，缺的是什么——记录、证照，还是流程？
3. 同行说：「广告审查证明太麻烦，先发了再说，被查到再删。」结合 1.4 节的罚则口径，算一算这个做法的期望成本。
4. 行业白皮书称 GEO 是「2026 最大红利：技术布局后流量免费」。你认同「流量免费」的说法吗？结合 1.2 节的打折提示，说出这句话成立的前提条件。
5. 动手实操：完成本章 1.7 节的四步练习，把你记下的「AI 答案里存疑的一处」带到第 2 章——它是学习幻觉核查的现成素材。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 1-1	对比图	种植牙集采前后价格对比：约 1.5 万元 → 7000 元；标注参与机构 1.8 万家、民营 1.4 万家占 80%	自绘（数据源：调研卡 #87 政策面 #2，经济观察报口径）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 1-2	时间线/地图	2026 年地方监管动作时间线：宝安 1 月 → 诸暨/福鼎 7-8 月 → 汕头 9 月 → 潜江 10 月，标注各场规模	自绘（数据源：各地监管部门公开信息）
图 1-3	示意图	四条合规高压线：广告（3-10 倍广告费）、药械（5-20 倍货值）、人员资质（6 年/5 年+培训）、财税（增值税法），共同底座标「日常留痕」	自绘
图 1-4	示意图	全书 12 章双线地图：局面与底盘（1-3）→ 增长线（4-7）→ 合规线（8-10）→ 人与长跑（11-12）	自绘

第 2 章 先把 AI 用明白：会提问比会工具更重要

本章导读

机构团队刚开始用 AI 时最常见的两个问题：一个是拿它当搜索引擎，问一句「种植牙疼不疼」就等着要标准答案；另一个是把它的输出直接对外发，结果文案里冒出编造的案例和不存在的优惠承诺。这一章不讲技术原理，只讲机构用 AI 必须知道的三条边界——幻觉、知识时效、上下文长度——和一个核心技能：提示词。医疗场景里幻觉的代价格外高：AI 编一段不存在的诊疗效果发出去是广告违法，编一条不存在的法规条款照着办是合规事故。读完这章，你能判断哪些活该交给 AI、哪些必须自己把关，并给机构建起第一版提示词库——运营、咨询、合规三个分区。

2.1 大模型是什么：懂到「会用」就够了

不必搞懂参数和架构，机构使用者只需要一个准确的图像：**大模型是一个读过海量文本的「超级实习生」——什么都会一点，写得快，但可能一本正经地编造，而且不知道自己不知道。**

这个图像解释了它的三件事：

它会写。科普文案、咨询话术、培训材料、差评回复，给它足够的背景信息，初稿质量能省掉一半起稿时间。这是机构用它的主要理由。

它会编。编造不是故障，是工作机制的副产品——它按语言规律生成「看起来像真的」的内容。被追问时甚至会顺着你的暗示继续编。医疗内容里，「看起来像真的」恰恰是最危险的品质。

它会过时。它知识有截止日期，而且不知道今天是几号。问它「2026 年抽查计划查什么」，它可能给你一个 2023 年口径的答案，语气一样笃定。

记住这个图像，三条边界就顺理成章了。

2.2 三条边界：幻觉、时效、上下文——医疗场景为什么格外致命

边界一：幻觉。AI 会编造不存在的事实：不存在的临床数据、不存在的患者案例、不存在的法规条款。通用场景里幻觉浪费的是时间，医疗场景里幻觉出的是事——

写进科普文案的编造数据，是虚假广告的素材；写进咨询话术的编造成功率，是对消费者的误导；写进培训材料的编造罚则，会让团队带着错误认知迎接检查。第 1 章练习里让你存疑的那个细节，就是幻觉的现场样本。

机构级的对策不是「小心一点」，是流程：**凡是对外发布的数字、案例、法规引用，必须人工核对原始来源；凡是 AI 给出的文号、条款号，默认存疑。**这条写进机构的内容管理制度，比写进任何提示词都管用。

边界二：知识时效。消费医疗恰恰是政策高频变动的行业：集采接续采购 2026 年 9 月刚启动规则，抽查计划 2026 年 3 月刚发文，海口合规清单 2026 年 7 月才发布。你让一个知识停在过去的系统回答这些，它答得越流畅越误事。

对策：涉政策的活，把材料喂给它。比如：

> **以下是我提供的一份合规指导清单的内容摘录（见分隔线内）。请只依据这份材料，回答：医美机构在广告宣传方面要做哪几件事？材料里没有的内容，直接说「材料未提及」，不要自行补充。**
>
> **———**
>
> **（粘贴海口清单广告部分的原文）**
>
> **———**

这个「材料内回答」的模式，后面每一章都会反复用——它同时压住了幻觉和时效两个风险。

边界三：上下文长度。AI 一次能处理的文本量有上限。你把一本机构手册、三份制度、十篇历史文案全贴进去，它只会记住其中一部分，忘了的部分它不会告诉你。

对策：一次对话只干一件事，材料按需喂。写一篇科普就只喂选题相关的背景；做一次自查就只喂对应维度的制度条款。长任务拆成多轮，每轮结束把结论复制存档，别指望它记住三天前的对话。

2.3 四要素骨架：把机构的活说清楚

团队用 AI 效果差，八成是提示词只给了一句话：「写一篇种植牙科普。」这等于对新来的实习生说「去写篇文案」——他只能靠自己猜，猜出来的就是你见过的那种广告腔。

有效提示词的骨架是四要素：**角色、任务、背景、要求。**

- **角色**：让 AI 站在谁的立场写。角色定语调——口腔医生、机构运营、合规顾问，写出来的东西完全不同。

- **任务**：具体做什么，做什么用途。一份「科普文案」和一份「平台笔记」的写法不一样。
- **背景**：机构信息、目标人群、已有素材。背景是四要素里最常缺、也最值钱的一项。
- **要求**：字数、结构、语气，以及——医疗场景特有的——合规约束。

看一个完整示例：

```
【角色】你是一位从业十年的口腔种植科医生，正在写面向普通患者的科普内容，语气亲切、不说行话。

【任务】写一篇 500 字左右的科普短文，主题是「种植牙为什么要拍 CT」，用于机构公众号。

【背景】目标读者是 40–55 岁、正在犹豫要不要种牙的患者；他们最担心的是疼和贵；我院使用口内扫描和 CBCT 术前评估；文中不要出现价格和优惠信息。

【要求】1. 开头用患者的一个真实顾虑切入，不要用「随着生活水平的提高」这类开头；2. 正文分 3 个小问题讲清「为什么必须拍」；3. 结尾提示「具体方案以面诊为准」，不要有任何疗效承诺和「 safest 」「最安全」这类绝对化表述；4. 语气像医生在诊室里聊天，避免广告腔。
```

注意「要求」第 3 条：合规约束直接写进提示词。这一条拦不住所有风险（第 8 章有完整清单），但能把最明显的坑提前避开——让 AI 一开始就不往那个方向写，比写完再改省事得多。

再给一个咨询场景的示例，展示「背景」怎么喂：

```
【角色】你是一家医美机构资深咨询师，风格专业、不推销。

【任务】一位客户在线上留资后问「你们家的热玛吉多少钱」，请写一段首次回复话术，100 字以内。

【背景】机构规矩：线上不报价，价格以面诊评估为准；这位客户是从科普文章进来的，对「抗衰」有明确兴趣；回复目标不是成交，是约到面诊。

【要求】1. 不出现具体价格；2. 给出一个「为什么要面诊才能报价」的专业理由；3. 结尾给一个低压力的到店邀请；4. 语气自然，像人打字，不要感叹号。
```

这两段提示词可以直接抄去改。你会发现改的过程本身就是一次机构信息梳理：你的客户怕什么、机构规矩是什么、哪句话不能说——写清楚提示词的过程，就是在写清楚机构自己。

2.4 机构提示词库：运营、咨询、合规三分区

用顺了的提示词别浪费。机构的做法很简单：建一个共享文档，按三个分区归档，格式统一——「提示词全文 + 一句话用途 + 最近一次使用效果」。

运营分区：科普文案、种草笔记、短视频脚本、团购套餐文案、差评回复、活动推文。特点是量大、模板化，AI 提效最明显。这个分区通常由运营负责人维护。

咨询分区：留资首响、邀约话术、异议处理参考、随访模板、客户回访。特点是重语境——同一个问题，从科普进来的客户和从团购进来的客户，话术不同。提示词里「背景」一项要写清客户来源。这个分区建议由咨询主管维护，并约定：话术初稿 AI 出，对外口径（价格、效果、风险）一律人工定稿。

合规分区：自查清单生成、培训材料整理、制度问答（喂了材料后的「材料内回答」模式）。特点是准确性优先于流畅性。这个分区的每条提示词末尾都固定带一句：「材料里没有的内容，直接说材料未提及，不要自行补充。」

三个分区各有一个负责人，库的规矩只有三条：新提示词先试用再入库；入库时写明用途；每月清一次——三个月没人用的删掉。提示词库不用追求大，二三十条用得顺手的，比两百条没人翻的有用得多。

2.5 选工具：通用大模型、诊所 SaaS、GEO 服务商各管什么

机构的 AI 工具不是一种，是三层。分清各层管什么，钱才不白花。

通用大模型：GLM、豆包、DeepSeek、文心一言等。管的是「写」和「分析」——文案初稿、话术、清单、材料问答。本章所有示例都在这层。优点是便宜灵活，缺点是没有你的机构数据，背景要每次喂。适合全团队使用，成本低到可以放开让员工练手。

诊所 SaaS 内置 AI：口腔医美 SaaS 已经把 AI 做进产品里——领健 e 看牙带 AI 病历、AI 影像分析，ABC 诊所管家是同类。这层管的是「业务系统里的活」：病历、影像、客户管理、预约。它有你的机构数据，提示词不用你写，但能力边界由产品定。机构要做的是把已购功能盘一遍，很多机构买了半年不知道里面有 AI。

GEO / AI 获客服务商：这层管的是「让 AI 在回答用户时提到你」——内容布局、结构化信息、可见度检测。市面上服务商已成体系，但水平参差、承诺浮夸（「包上 AI 首页」这类话术要警惕，第 5 章给甄别方法）。适合有预算、把 GEO 当长期渠道的机构。

三层的分工一句话：**通用大模型是全员的基础技能，SaaS 是业务流程的工具，GEO 服务是渠道投资**。先把第一层用起来（成本几乎为零），再盘第二层（已有预算），最后考虑第三层（新增预算）。顺序反了的机构不少——GEO 服务买了两万块的，全员连提示词四要素都还不会写。

动手练习

把你机构的真实业务喂给 AI，做一条「咨询分区」提示词。步骤：

1. 新建对话，把下面骨架补完整后发送：

【角色】你是一家（口腔/医美）机构的资深咨询师。

【任务】客户问「(填一个你们客户最常问的问题)」，写一段首次回复，100 字以内。

【背景】机构规矩：(填你的机构规矩，比如线上不报价/需面诊评估)；客户来源：(填：科普文章/团购/老客户转介绍)；回复目标：(约面诊/进群/留电话)。

【要求】1．不出现具体价格；2．不做任何效果承诺；3．结尾给一个低压力的下一步动作；4．语气自然像人打字。

2. 核对输出：有没有偷偷塞进价格暗示？有没有「绝对安全」「终身保障」类绝对化表述？有没有编造「我们做了 XX 例」这类没有出处的数字？
3. 迭代一轮：把发现的问题写进「要求」，重发，对比两版差异。
4. 存档：把改好的提示词写进机构提示词库的咨询分区，格式按 2.4 节的三件套。

思考题

1. 「把 AI 输出直接发出去」和「AI 初稿、人工定稿」，差的那一步具体是在防什么？用本章三条边界各说一个会翻车的场景。
2. 你的机构里，哪个岗位最适合先吃透提示词四要素？为什么不是全员平均用力？
3. 2.5 节说「GEO 服务买了两万块的，全员连四要素都不会写」。这个顺序错在哪？如果预算只够投入一层，你会投哪层？
4. 「材料内回答」模式（材料里没有的直接说材料未提及）为什么能同时压住幻觉和时效两个风险？它防不住什么？
5. 动手实操：完成 2.6 节练习，并把机构提示词库的三个分区建起来——哪怕每个分区只有一条，也比空白强。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 2-1	示意图	三条边界示意：幻觉（编造）、时效（知识截止日）、上下文（一次处理量上限），各配一个医疗场景翻车例子	自绘
图 2-2	结构图	提示词四要素骨架：角色/任务/背景/要求，右侧标注每要素「缺了会怎样」	自绘

图号	类型	内容说明	来源建议
图 2-3	表格图	机构提示词库三分区：运营/咨询/合规，各区列 3 条示例提示词与维护人	自绘
图 2-4	分层图	工具三层：通用大模型（全员技能）→ 诊所 SaaS（业务流程）→ GEO 服务（渠道投资），标注成本与适用顺序	自绘

第 3 章 获客账本与 AI 路线图：3000 元一个人的仗怎么打

本章导读

第 1 章摆了局面，这一章把获客这笔账算透。3000 元一个人的获客成本不是从天上掉下来的，它花在平台投放、内容制作、咨询人力、到店转化损耗四个地方——每一处的浪费模式不一样，AI 能省的位置也不一样。集采之后客单价腰斩，这笔账必须重算：按公开口径粗算，3000 元获客成本摊在 7000 元的种植牙客单价上，占比已过四成。章末给出 AI 获客的五条路（内容种草、GEO、本地生活团购、私域裂变、咨询提效）和一张按机构体量分档的起步路线图。读完这章，你手里应该有一本自己机构的获客账，和一条明确先走哪条路的决定。

3.1 获客成本是怎么花出去的

行业白皮书的口径：医美行业平均获客成本突破 3000 元/人。这个数是全行业平均，你的机构可能高于它，也可能低于它——所以第一件事是算自己机构的账，别用行业平均数骗自己。

获客的钱大致花在四个地方。每一处的算法和浪费模式不同：

第一处：平台投放费。信息流广告、搜索竞价、达人合作，这是大头，也是最容易被「再投一点就有效果」话术拖着加码的地方。投放的浪费模式是漏斗：曝光到点击漏一次，点击到留资漏一次，留资到到店再漏一次——每一层都在花钱，最后一层漏掉的线索，前面的钱全部白花。

第二处：内容制作费。自己拍要养团队，外包拍按条计价。很多机构的内容成本是隐性的人力和时间，没进营销科目，所以老板经常低估它。浪费模式是低效复用：一条视频拍完只发一个平台，二十条旧内容从来不起作用。

第三处：咨询人力。咨询师团队是消费医疗特有的人力结构，工资加提成不便宜。浪费模式是响应延迟和无效跟进：留资线索半小时才回，客户早问了别家；对没意向的客户反复人工跟进，时间花在不产出的人身上。

第四处：到店转化损耗。线上聊得好好的，到店聊崩了；面诊完说「回去考虑一下」，再也没回来。这部分不直接花钱，但它是前面三处投入的最终折损——前面花 3000，这里掉一半，实际成本就是 6000。

算自己机构的账，就按这四处列。投放费看后台，内容成本把人力工时折进去，咨询人力看工资表和线索量，转化损耗用「留资数 → 到店数 → 成交数」三个数一除就有。数字丑没关系，丑的账才是能改的账。

3.2 集采之后，这笔账必须重算

集采之前，这笔账很多机构是不算的：种植牙客单价一万五，获客三千，占比两成，毛利厚，扛得住粗放。

集采之后账变了。单颗均价约 7000 元（第 1 章口径），3000 元的获客成本占比直接超过四成。同一个获客成本，在旧客单价下是两成，在新客单价下是四成多——**获客成本没变，但它的杀伤力翻倍了。**

这道算术背后是一个结构性事实：收入端被集采压下来了，成本端不会自动跟着降。机构只有两条出路：要么把获客成本打下来，要么把客单结构调上去（多做复购、转介绍、多项目组合）。而这两条路的工具恰好是同一批——AI 获客降的是第一笔账，私域和复购运营抬的是第二笔账。

给一个重算的动作：把你机构主打项目的客单价、当前获客成本摆在一起，算占比；再算「如果获客成本降到一半，利润多出多少」。第二个数通常比任何营销课都有说服力——它就是这本书后面四章要帮你挣的钱。

3.3 AI 获客的五条路：一张地图

AI 在获客上的用法，收拢起来是五条路。每条路给「省在哪」的判断：



图 3-1 AI 获客五条路地图：内容种草/GEO/本地生活/私域/咨询提效，标注各自省钱位置与见效周期

第一条路：内容种草。AI 把内容的边际成本打下来——过去外包一条图文几百块、养内容团队一个月几万块，现在 AI 出初稿、医生改定稿，产能上去了，单价下来了。省的是第二处成本。见效周期以周计，是五条路里性价比最高的起步选择。第 4 章展开。

第二条路：GEO。让大模型在回答「XX 城市 XX 项目哪家好」时提到你。白皮书叫它「2026 最大红利」，理由是技术布局后流量免费——不用按点击付费，用户问 AI、AI 推荐你、客户来找你。省的是第一处投放费的一部分。见效周期以月计，是投资型动作。第 5 章展开。

第三条路：本地生活团购。团购套餐把「广告位」变成「货架」，客户带着明确意愿进店。AI 帮在套餐文案、评价回复、装修图文这些高频低难度的地方。省的也是投放费——团购的流量成本一般低于信息流。见效周期短，适合和内容线并行。第 6 章展开。

第四条路：私域裂变。把到店客户变成可反复触达的私域资产，复购和转介绍的单个客户成本远低于拉新。AI 帮在分层跟进话术、朋友圈内容、社群运营节奏。省的是长期获客账——老客带新客的信任浓度，是任何广告买不来的。第 6 章后半展开。

第五条路：咨询提效。AI 帮咨询师处理首轮响应、跟进提醒、话术参考，把人的时间留给高意向客户。省的是第三处人力和转化损耗——响应快了，留资到到店的漏损就小了。这是最容易被低估的一条：它不直接「获客」，但它决定前面四条路流进来的线索有多少不被浪费。第 7 章展开。

五条路不是并列选项，是配合关系：内容是弹药，GEO 和本地生活是阵地，私域是护城河，咨询是收口。预算和时间有限时，按下面分档决定先走哪条。

3.4 GEO 为什么被叫作「2026 最大红利」

把白皮书的说法原样放在这里：GEO 被称为「2026 最大红利：技术布局后流量免费」。

这句话要拆成两半读。前半句「最大红利」是判断，可以商榷；后半句「技术布局后」是前提，**这个前提比结论重要得多。**

逻辑是这样的：越来越多用户开始拿消费决策问 AI——「我这个情况适合做什么项目」「本地哪家机构口碑好」。AI 的回答基于它能检索到的公开信息：机构的科普内容、资质公示、案例、口碑信息。谁的内容在 AI 检索得到、引用得上的位置，谁就出现在回答里。这和二十年前做搜索排名是同一个结构的游戏，只是搜索框换成了对话框。

「布局后流量免费」的意思是：布局是一次性的内容与信息工程，布局完成后，每一次 AI 推荐都不按点击收费。对比信息流按点击计费的模型，这确实是成本结构上的代差。

但要泼三盆冷水：

第一，**布局不是免费的。**结构化信息、持续更新的科普、口碑沉淀，都是内容和运营工作。说「免费」省掉的只是流量采购费，不是运营成本。

第二，**见效以月计**。AI 的信息源更新有周期，今天布的内容，可能几周后才进回答。把它当三个月的渠道投资来规划，别当这个月的救命稻草。

第三，**服务商承诺要打折听**。「包上 AI 首页」「保证 AI 推荐你家」这类承诺，兑现机制说不清的都是话术。第 5 章会讲怎么自己检测 AI 可见度——检测能力在自己手里，才不容易被忽悠。

一句话总结这节：红利是真的，前提是布局；布局是自己能干的活，不必然要外包。

3.5 分档起步：单店、连锁、医生工作室各先做什么

五条路全上的机构很少，预算和人手都有限，按体量给起步建议：

单店/单体诊所：先走内容 + 本地生活，同步搭咨询话术底座。 单店最缺的是曝光，最经不起的是投放。内容种草成本低、复用久；本地生活团购带来的是带意愿的精准流量，两者都吃「AI 产能 + 人工定稿」的同一个流程，一套人马两条线。投放（第一处成本）暂时按住不加——等内容线跑出十篇能稳定带留资的稿子，再考虑要不要投。GEO 布局可以顺手做：把科普内容、资质信息按第 5 章的清单布到位，不额外花钱，等它自己发酵。

连锁机构：先走 GEO + 私域，内容做总部模板。 连锁的痛点不是单店曝光，是品牌在 AI 回答里的整体形象和跨店的客户资产。GEO 布局是总部级工程，一次投入全店受益；私域把各店客户收进统一体系，复购和转介绍跨店流转。内容线总部出模板、各店本地化，别每家店各自为战。投放可以在数据好的单店试点，别全线上。

医生工作室/个人执业：先做医生 IP，内容即渠道。 工作室的获客逻辑是信任浓度而非流量规模——患者认的是医生这个人。第 11 章的医生 IP 打法就是主线：科普型账号、AI 辅助生产、资质合规展示。IP 起来之前，本地生活团购托底基本盘。

三档共同的起点是同一个：第 2 章的提示词能力。五条路每一条都跑在「AI 出初稿、人定稿」这个流程上，流程不通，五条路条条堵。

动手练习

给你机构的获客账做一次「四处拆解」，并算出降本空间。步骤：

1. 打开大模型对话，发送（按你机构情况填空）：

> **你是一位消费医疗机构的运营顾问。我是一家（城市）（口腔/医美）机构，主营项目（填项目名），客单价约（填）元，上月获客总投入约（填）元，到店新客（填）人。请帮我：1．算出单个到店客户的获客成本；2．把「平台投放/内容制作/咨询人力/到店转化损耗」四个成本处各设计 2 个具体的核查问题，帮我在内部开会时逐项盘账；3．按「见效周期从短到长」给我排一个 AI 获客五条路（内容种草/GEO/本地生活/私域/咨询提效）的尝试顺序建议。注意：所有建议基于我给的数字，不要编造行业基准数据。**

2. 核对输出：它算的获客成本对不对（总投入 ÷ 到店数）？它编没编「行业平均转化率」之类你没给的数字——编了就要求它删掉。
3. 带着它的核查问题表，开一次 30 分钟的内部盘账会，四处各盘出一个真实数字。
4. 把「见效周期排序」的建议和第 3.5 节的分档对照，写下你机构未来 90 天先走的两条路。

思考题

1. 用你机构的真实数字重算 3.2 节那道题：主打项目客单价 × 当前获客成本占比；再算获客成本减半后利润多出多少。这两个数你以前算过吗？
2. 3.1 节说到店转化损耗「不直接花钱，但决定前面投入的最终折损」。按你的直觉估：留资到到店、到店到成交，你的机构各折损几成？哪里最该先补？
3. 「布局后流量免费」的前提是布局。如果把 GEO 外包给服务商，机构自己还需要保留哪些动作？（提示：检测能力、内容质量、资质真实性）
4. 你的机构属于哪一档（单店/连锁/医生工作室）？对照 3.5 节的建议，你现在的投入顺序对吗？列出一条你现在在做、但应该往后放的事。
5. 动手实操：完成 3.6 节的四步练习，产出你机构的「四处盘账」真实数字和 90 天路线——这是后面四章每章方法能不能落地的账本基础。

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 3-1	地图/示意图	AI 获客五条路：内容种草/GEO/本地生活/私域/咨询提效，标注各自省哪处成本与见效周期	自绘
图 3-2	数据图	获客成本占比对比：集采前（客单 1.5 万，占比约两成）vs 集采后（客单 7000，占比四成多），按公开口径粗算标注	自绘

图号	类型	内容说明	来源建议
图 3-3	漏斗图	获客四处成本与漏斗：曝光→点击→留资→到店→成交，标注各层折损与对应的 AI 介入点	自绘
图 3-4	表格图	分档起步路线表：单店/连锁/医生工作室三档，先走、并行、暂缓三列	自绘

第 4 章 内容种草：科普与口碑内容的合规批量生产

本章导读

内容是获客的弹药库，也是 AI 提效最直接的位置——但消费医疗的内容有一条别行业没有的约束：每一篇都可能被认定为医疗广告。这一章给一条「AI 出产能、医生出判断」的内容流水线：选题从患者高频问题里来，AI 初稿把合规约束预埋进去，医生改三处必须人改的地方，再按平台改形态、按周排期。产能的账算给你看：这条流水线在什么参数下比外包便宜，什么参数下反而更贵。红线判定方法在第 8 章展开，这一章先把生产线跑起来。

4.1 选题从患者嘴里来，不从爆款库里抄

同一个「洗牙」选题，两种来路，结果不同。来路一：市场部让 AI「写一篇洗牙科普」，AI 从通用语料里捞出千篇一律的内容，发出去和同城同行撞脸，读者没有理由记住你。来路二：运营翻咨询记录，发现「洗牙会不会伤牙」本周被问了 12 次，拿这个问题成稿——它在你的机构里已经被验证过有人问，这篇内容是给正在犹豫的人一个进店理由。

判断是：**患者真实问过的问题，才是有效选题**。爆款榜抄来的选题自带别人的语境，你的机构接不住，也回答不了后续咨询。

落地动作是建一张「高频问题库」共享文档，三列：问题原文、被问次数、记录渠道（线上咨询/面诊/术后随访）。维护机制定死两件事：咨询团队周例会留 15 分钟过一遍本周问题（超时提问的按次数排序补充）；问题原文照录不加工——患者口语就是最好的钩子素材，「洗完牙缝真的会变大吗」比运营转写的「洁牙后牙缝变化的相关疑问」生动一个量级。运营每周从库里挑 3-5 条转成选题。AI 在这一步的用法是批量转换，提示词如下：

```
【角色】你是一家口腔机构的运营策划。
【任务】把下面这批患者高频问题转成内容选题清单，每条给：选题角度、目标人群、适配平台（公众号/图文笔记/短视频/问答）、一句话切入钩子。
【背景】以下是本周咨询记录里被问最多的问题（见分隔线内）；机构主推种植与正畸项目；目标读者以 30–55 岁本地居民为主。
【要求】1. 每个问题只出 1 条选题；2. 切入钩子从患者顾虑出发，不出现价格与优惠信息；3. 不使用「最」「第一」「保证」类表述；4. 用表格输出。
————
```

```
（粘贴本周高频问题 10–20 条）
————————
```

什么情形下不灵：新项目刚上线、没有历史咨询积累时，问题库是空的。这一档的选题要靠医生在面诊里的观察记录、评论区里患者的真实提问来冷启动——对市场缺口的判断是人的活，AI 替不了。

4.2 AI 初稿：把红线写进提示词，比写完再改省事

初稿质量的分水岭不在「AI 好不好」，在提示词的「背景」和「要求」两栏喂了什么。第 2 章的四要素骨架在这里长成完整形态——注意「要求」里预埋的合规约束，让 AI 从第一句就避开广告腔，比成稿后逐句删改省事：

```
【角色】你是一位从业十年的口腔种植科医生，正在写面向普通患者的科普内容，语气亲切、不说行话。
【任务】写一篇 600 字左右的科普短文，主题是「洗牙会不会伤牙」，用于机构公众号图文。
【背景】目标读者是 30–50 岁、听说洗牙会让牙缝变大所以不敢洗的人；他们的真实顾虑是「洗了以后牙齿酸、缝变宽」；我院使用超声洁治与喷砂抛光；文中不出现价格与优惠。
【要求】1. 开头用患者的原话顾虑切入，不用「随着生活水平提高」类开头；2. 正文讲清三件事：牙结石是什么、洗牙洗掉的是什么、为什么有人洗完感觉缝变宽；3. 结尾落到「具体情况以面诊检查为准」，不做任何疗效承诺，不出现「绝对安全」「无痛保证」类表述；4. 语气像医生在诊室里聊天，删除「我们的技术领先」「选择我们的五大理由」类广告腔。
```

广告腔的识别口径只有一条：科普的说服力来自讲清原理，不来自夸自己。凡是主语是「我们」且在作评价的句子，初稿阶段直接删。标题也在初稿检查范围内——AI 生成的科普标题有明显的「标题党」倾向（「99% 的人都不知道」「医生绝不会告诉你」），点击率换来的是信任透支，与科普型定位背道而驰，标题按「问题原话」风格重拟。

什么情形下不灵：AI 训练语料里的营销话术习惯压不干净，合规约束写进提示词只能降低概率、不能清零——「有效率高达 95%」这类句子仍可能冒出来。兜底的一环是发布前的人工检查，方法在第 8 章；这一章的纪律是：**没有医生审签的内容不发布**。

4.3 医生改稿：三处必须人来改的地方

流水线里医生这一站不能省，但可以压缩到二十分钟以内。改什么，三处：

第一处：数字与临床表述。 AI 给的所有数字、机制解释必须由医生核一遍来源。AI 初稿写「洁牙后牙结石复发率约 30%」，医生第一反应该是「这个数哪来的」——说不出处的数字，要么换成「因人而异」，要么删。这是第 2 章幻觉防线在内容线上的人力落点。

第二处：分寸感。「一般情况」「多数患者」「少数人可能」这些限定语的松紧，医生比 AI 懂临床分寸。AI 容易把话说满，医生负责把话说准。

第三处：署名与责任。改定稿的医生在文末署名，署名不是形式——读者按署名找上门，出了表述争议也按署名追责。署名的仪式感就是这条流水线的质量闸。

什么情形下不灵：医生赶时间、跳过审签直接发，整条流水线等于裸奔。这一档没有任何 AI 替代方案——流程上要么配好医生的固定审稿时段（比如每周两个下午各 40 分钟集中审签），要么减少发布量。产能向审稿能力低头，不反过来。

4.4 分平台适配：一条母稿的四种长相

同一选题不必四平台各写一遍。母稿定稿后，AI 做形态改写，一张对照表说清各平台的差异：

平台形态	内容重点	长度参考（假设经验值）	改写要点
公众号图文	讲全讲透，结构清晰	600-1000 字	母稿可直接用，配图 2-3 张
图文笔记	讲轻讲碎，一句一段	300-500 字	拆小标题、加口语、结尾一句互动提问
短视频口播	钩子开头，口语短句	200-300 字（约 60 秒）	前 3 秒必须抛出患者原话式问题
问答平台	直接回答，先结论后解释	400-600 字	第一句就回答「会不会伤」，再展开

形态改写的提示词把母稿贴进「背景」栏即可，要求栏写明目标平台的形态要点。形态之外还有一层复用叫系列化：一个被问得特别多的问题（比如种植牙的疼），值得拆成系列而不是一篇——现象篇（种牙到底怎么个疼法）、原理篇（现代种植的疼痛控制逻辑）、决策篇（什么情况适合做）。系列内容互相引流，把一个问题的搜索流量全部收进自己的内容资产里，这是单篇内容做不到的。

什么情形下不灵：形态改写不等于合规改写。短视频的钩子若配上「术前术后对比」画面，触发的就不是文案问题而是案例展示的边界问题（第 8 章）；各平台医疗类目的认证要求与内容限制不同且持续更新，发布前要对照平台现行规则——平台规则卡的做法在 8.4 节。

4.5 排期与复盘：产能的账在什么参数下成立

排期表三要素：发布时间、平台、责任人（谁审签、谁发布）。产能目标要贴着审稿能力定：每周稳定 3-5 篇，好过爆发一周然后停更——内容是复利型资产，断更等于清零重来。

这条流水线到底比外包省多少，用一道算例说清。**以下全部是假设参数，用于演示算法，不是实测：** 外包图文按 300 元/条计；AI 流水线的成本是人力——运营排版 15 分钟、医生改稿 20 分钟，按医生时薪 300 元、运营时薪 60 元算，单条成本约 115 元，约为外包的四成。结论似乎是流水线必赢。

但把参数动一动，结论会翻转：如果选题生僻、AI 初稿质量差，医生改稿涨到 60 分钟，医生环节单条 300 元，总成本约 315 元，反超外包。按本例时薪算，翻转点在医生改稿时长约 57 分钟——五元一分钟的医生时间，把 115 元的成本拉回 300 元只需要一小时。

改稿时长被什么决定？选题是不是从患者高频问题里来（4.1），红线是不是预埋进了提示词（4.2）。 前两节做扎实，这道账就成立；前两节偷懒，流水线比外包还贵。

复盘看什么：看留资，不看阅读量。复盘动作做成填表而不是开会——排期表加三列：选题编号、发布平台、本周带来咨询数，发布时留空、周会填数。哪类选题带来咨询，下期多写哪类；连续四周零咨询的选题类型，从选题池降权。复盘结论写回高频问题库，生产线闭合成环。阅读量是平台的指标，留资才是机构的指标。

动手练习

从你机构咨询记录里挑一个本周被问过至少 3 次的问题，完整走一遍流水线：

1. 按 4.1 的提示词把它转成选题，确定目标平台。
2. 按 4.2 的提示词出 AI 初稿，检查初稿里有没有「我们」作主语的评价句、有没有无出处的数字——各标出来。
3. 请一位医生按 4.3 的三处改稿，记录医生实际用了多少分钟——拿这个数和 4.5 算例里的 20 分钟对照，你就知道自己机构的账在翻转点的哪一侧。
4. 按对照表改出第二个平台版本，发布前把「这句算不算医疗广告」逐句问一遍，拿不准的句子记下来，带去第 8 章对答案。

思考题

1. 4.5 的算例里，翻转点在医生改稿时长约 57 分钟（按时薪 300 元算）。把你机构医生的真实时薪代进去重算：你的翻转点是几分钟？它离你现在流水线的实际改稿时长有多远？
2. 「产能向审稿能力低头」——如果你机构医生每周只能给出 80 分钟审稿时间，按每条 20 分钟算，你的周产能上限是几条？现在排期表排了几条？
3. 复盘看留资不看阅读量。翻你机构最近十条内容，哪条阅读量最高、哪条带来的咨询最多——是同一条吗？如果不是，差在哪？

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 4-1	流程图	内容流水线全景：问题库 → 选题 → AI 初稿 → 医生改稿（三处）→ 平台适配 → 发布 → 留资复盘回问题库	自绘
图 4-2	对照表	一条母稿改四平台：公众号/图文笔记/短视频/问答的内容重点与改写要点	自绘

图号	类型	内容说明	来源建议
图 4-3	算例图	流水线成本算例：外包 300 元/条 vs AI 流水线 115 元/条，标注翻转点（改稿约 57 分钟）与「假设参数」角标	自绘
图 4-4	示意图	医生改稿三处：数字与临床表述、分寸感、署名与责任	自绘

第 5 章 GEO：让 AI 回答里带着你

本章导读

客户问 AI「本市种牙哪家机构靠谱」，回答里有没有你，取决于 AI 能在公开信息里查到谁、验证得了谁——这一问一分钱广告费都不花。GEO（生成式引擎优化）就是让你出现在这个回答里的打法，行业白皮书称它「2026 最大红利：技术布局后流量免费」。这一章讲清三件事：AI 回答引用谁的规律、机构信息怎么布到会被引用的位置、怎么用 AI 自己检测「AI 可见度」；再给一盆必要的冷水：见效以月计，谁承诺包上推荐谁就可疑。

5.1 AI 回答里的位置是攒出来的，不是买出来的

同一个「种牙去哪」的提问，问 AI 和搜引擎是两场不同的考试。搜索引擎给一个列表，你的竞价排名能买到前排；AI 给一个回答，回答里点名三两家机构——**没有广告位可买**。用户看到的不是十家候选，是一个已经被 AI 筛过的短名单。

判断是：**GEO 的门票靠公开信息攒出来，花钱买不来现成位置**。这也是白皮书那句「技术布局后流量免费」的正确读法——「免费」说的是布局完成后不按次付费，「布局」说的是先得有一段内容与信息工程。跳过布局谈免费，是把愿景当现状。

和投放对比，两笔账性质不同：投放买当次曝光，钱停效果停；GEO 布局是资产，科普内容、资质公示、口碑沉淀一次布好持续起效。所以第 3 章把它归为「投资型动作」，见效以月计——AI 信息源的更新有周期，今天布的内容，可能几周后才进入回答。

什么情形下这条判断不灵：个别服务商确有渠道能短时间改变部分平台的回答呈现，但机制不透明、稳定性存疑。遇到「一周见效」的说法，先拿 5.4 节的检测方法验证，验证不了就不付钱。

5.2 AI 回答引用谁：可验证性优先于宣传性

AI 回答「本地哪家机构好」这类问题，依据是它能检索到的公开信息。观察这些回答的引用规律，一句话概括：**可验证性优先于宣传性**。

AI 倾向引用的信息，按权重从高到低：

信息类型	例子	为什么被引用
公开可验证的资质信息	执业许可公示、卫健部门公示平台上的登记信息	有官方来源，可交叉核验

信息类型	例子	为什么被引用
持续更新的科普内容	讲原理、讲适应症的科普文章与问答	事实性强，回答问题时可直接取用
第三方平台的真实口碑	本地生活平台的评价与评分	聚合了多个独立来源的判断
机构自营的宣传页	「技术领先」「海量案例」类官网文案	自述不可验证，权重低

规律倒过来读就是布局位置：AI 抓得到哪里，就把结构化信息放到哪里；自夸的文案引用权重低，写了也白写。这一条对机构是个好消息——布资质、布科普、攒真实口碑，都是自己能干的活，不必先外包。另有一层时间维度的规律要知道：AI 信息源的更新有周期，主流产品从几天到几周不等，且各产品抓取的来源清单不同——同一份布局，在不同 AI 里的见效节奏不一样，这也是 5.4 节检测要用两三个模型分别实测的原因。

什么情形下不灵：各 AI 产品的信息源与更新机制不公开且持续变化，「哪些位置权重高」是经验归纳，不是官方规则。检测（5.4 节）因此必须常态化，拿实测校准经验，别把任何一张来源清单当成永久真理。

5.3 布局三件套：资质、案例、科普，一致性是命门

机构 GEO 布局收拢成三件套，件件都有「一致性」这条命门：

资质件。执业许可、医师资质、地址电话，在官网、公示平台、本地生活平台、公众号各处必须口径一致——机构名称一字不差、地址同一写法、医生姓名与执业注册一致。AI 回答前会交叉验证多个来源，对不上的信息不仅不被引用，还可能让整家机构在回答里被跳过。布局资质件的动作是拿一张核对表落地：行是核对字段（机构全称、地址、联系电话、医生姓名与执业编号、科室设置），列是公开渠道（卫健公示平台、官网、公众号、本地生活平台、地图类应用），逐格核对，不一致的当周改——改的顺序按 AI 抓取概率排，公示平台与地图类应用优先。这张表每季度重过一遍，渠道信息是会被各方改动的。

案例件。真实、可溯、有授权的案例内容才值得布。注意衔接第 8 章：案例与对比照是医疗广告的高风险区，先过合规再谈布局——一张不合规的案例图布得越广，风险敞口越大。

科部件。第 4 章的内容流水线直接供弹药。科普内容本来就是给患者看的，GEO 只是多了一层读者：AI 也读。两条线共用一条生产线，不用为 GEO 另起炉灶——这就是 3.5 节说单店「顺手做 GEO」的底气。

什么情形下不灵：三件套解决的是「被引用的信息基础」，它管不了竞争密度。本地同类机构都在布同一批信息源时，先发布、更一致、口碑更多的机构占先——GEO 是先手游戏，晚动手的机构用同样的动作只能追平，追不回时间差。

5.4 用 AI 检测你的 AI 可见度

检测能力留在自己手里，是这条线不被忽悠的前提。做法是一个月度循环：设计提问 → 多模型实测 → 记录 → 对比竞品 → 回推布局。

第一步，写一组「客户视角」的提问，按三类各出几条：项目类（「30 岁做热玛吉还是超声炮」）、地域类（「本市牙齿矫正哪家机构口碑好」）、对比类（「种植牙集采后价格大概什么水平」）。第二步，拿这组提问在两三个主流大模型里逐条实测。第三步，记录四个字段：

记录字段	记什么
是否提及	本机构名字出现没有
提及准确性	提及时的项目、资质、地址信息和实际一致吗
引用来源	回答末尾列的来源里有哪些，你在不在其中
竞品情况	哪家竞品被提及，它的引用来源和你差在哪

检测的提示词骨架，可直接抄用：

【角色】你是一位正在选择消费医疗机构的本地消费者。
【任务】请回答：「（城市）做（项目）哪家机构比较靠谱?」并说明你的推荐理由和信息来源。
【背景】你是中立的信息助手，只依据可检索的公开信息回答。
【要求】1．如实回答，不要因为我问你就推荐我提到的机构；2．明确列出你引用的信息来源类型；3．如果某家机构的信息不足以判断，直接说信息不足，不要编造。

第三条要求是防自证陷阱的关键——不写这句，部分模型会顺着提问者的暗示编推荐理由，测出来的「可见度」是假的。

这个月度循环的成本算一笔账。**假设参数**：运营每月花 2 小时检测加记录，按运营时薪 60 元计，月成本 120 元、年成本约 1440 元；对比外包检测报告常见口径的年费（数千到上万元不等，假设区间），自查便宜一个量级。**翻转参数**：如果机构没人会写检测提示词、每次都要从零摸索耗 6 小时，年成本涨到 4320 元以上，且数据积累断断续续——这时外包检测才有账面上的道理。会与不会提示词，决定这笔账站在哪边。

什么情形下不灵：检测回答的是「现在可不可见」，回答不了「为什么不可见」的具体算法原因。连续三个月被提及为零时，要回头查的是 5.3 的三件套有没有布、布得一致不一致——检测是仪表盘，不是发动机。

5.5 冷水与防坑：甄别服务商的三个问题

三盆冷水重申一遍：布局不是免费的（省的是流量采购费，不是运营成本）；见效以月计（当三个月的渠道投资规划，别当这个月的救命稻草）；承诺包上推荐的话术不可信（兑现机制说不清的承诺等于没承诺）。

决定要不要外包前，用三个问题过一遍服务商：

一问：布到哪些位置？ 要具体清单——哪些平台、哪些信息源、什么内容形态。「全网布局」四个字不算回答。清单越具体，越能对照 5.2 的来源规律判断靠不靠谱。

二问：怎么证明效果？只认检测报告，不认截图。让他用你机构自己的提问组、按 5.4 的记录字段出报告，基线数据在签约前先测一轮——没有基线，三个月后他说「涨了」你无从对证。

三问：内容谁生产？ AI 批量灌水式生产对 GEO 有害——低质内容稀释机构信息质量，还可能批量触碰广告红线（第 8 章）。内容质量是这条线的入场券，不是可选项。

三个问题都答得具体的，再回到第 3 章的账本逻辑决策：你机构的获客成本占比、客单结构、能分给这条线的人力，合起来决定外包值不值。预算逻辑在账本里，不在服务商的话术里。

什么情形下外包确实合理：连锁机构多店多项目、内容量大、总部有人能验收报告——外包做内容产能，检测与资质一致性自己留。单店两样都不占的，先把 5.3 的三件套自己布完，三个月后再谈要不要花钱。

动手练习

给你机构做第一份「AI 可见度检测报告」：

1. 写 9 条提问：项目类 3 条、地域类 3 条、对比类 3 条，全部用你客户的口吻。
2. 按 5.4 的提示词骨架，在两个主流大模型里逐条实测，按四字段表格记录。
3. 找出本地在回答里被提及最多的一家竞品，对比它的引用来源和你机构的差集——差在哪类信息，就是 5.3 三件套里你缺的那件。
4. 把缺项写成一条本月布局动作（改一致、补科普、或补口碑），写进排期表，下月检测时验证。

思考题

1. 「AI 回答里的位置是攒出来的，不是买出来的」——你认同吗？如果一家服务商给你看了一份「客户被 AI 提及」的成功案例，你会用本章哪一节的方法去验证它？
2. 5.3 说资质一致性是命门：现在就打开你机构在三个不同渠道的页面，核对名称、地址、医生名单——有几处对不上？对不上的那一处，AI 交叉验证时会发生什么？
3. 5.4 的成本算例里，「会不会写检测提示词」决定了外包账站在哪边。按你团队现状，这道账站在哪边？如果站在外包那边，缺的是技能还是人手？

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 5-1	对比图	搜索列表页 vs AI 回答：十家候选 vs 被筛过的短名单，标注「无广告位可买」	自绘
图 5-2	权重图	AI 引用来源四层：资质公示/科普内容/	自绘

图号	类型	内容说明	来源建议
		第三方口碑/自营宣传页，权重从高到低，标注「可验证性优先于宣传性」	
图 5-3	清单图	布局三件套：资质/案例/科普，各列布点位置与「一致性」要求	自绘
图 5-4	流程图	AI 可见度月度检测循环：设计提问 → 实测 → 四字段记录 → 对比竞品 → 回推布局	自绘

第 6 章 本地生活与私域：把流量接住养起来

本章导读

消费医疗是本地生意，流量接不住等于白花钱。这一章管两个「接流量」的阵地：本地生活团购——把广告位变成货架，用引流款把人带进店；私域——把到店客户变成可反复触达的资产，靠复购和转介绍摊薄获客成本。AI 埋在每一环里：套餐文案、差评回复初稿、分层跟进话术与节奏提醒。医疗场景有一条贯穿的沟通边界：什么能线上主动说、什么必须留到面诊——这条边界既是合规要求，也是转化效率的分水岭。

6.1 套餐双层结构：引流款把人带进店，医生把人留下来

两家机构都上架了低价洁牙引流款，命不同。甲把引流款当利润款经营：客户到店后，咨询师层层加项、不检完不放过，客户付了钱感觉被套路，差评、拉黑、告诉朋友别去。乙把引流款当门槛用：到店先由医生做检查、讲口腔状况、给方案，加不加项目客户自己定——有人只洗了牙就走了，也有人从洁牙客户变成长期正畸客户。同样的团购，甲亏掉的是口碑，乙亏掉的只是引流款那一单的小额补贴。

判断是：**引流款的定价逻辑是「降低第一次到店的门槛」，不是「打折促销」；它只负责把人带进店，进店之后由医生的方案沟通决定成败**。「低价进门、高价逼单」是私域和口碑的双输打法——当单收了钱，丢的是往后每一单。

这道账要按到店后的转化算，不能按卖了多少份算。**以下全部是假设参数，用于演示算法**：引流款定价 99 元，材料加人力成本 80 元，每来一人到店亏 19 元；到店客户转化利润款的比例 20%，利润款客单价 2000 元、毛利按 40% 计 800 元——每个到店客的期望毛利是 160 元，减去 19 元补贴，净 141 元。把转化率这个参数动一动：掉到 10%，期望毛利 80 元，净 61 元；掉到 5%，还剩 21 元——这道账真正翻亏要跌破约 2.4%（19 元补贴除以 800 元毛利的临界转化率）。数字读出来的结构是：折扣带来的亏损有小兜底，真正的敏感参数是转化率——它在 141 和 21 之间摆动，决定了这道账是厚是薄。**而转化率由医生沟通与流程体验决定，不由折扣力度决定**。折扣打得再狠，救不了转化率。

AI 在套餐环节的位置是文案：引流款的卖点描述、适用人群说明、到店流程告知。提示词沿用第 2 章四要素，要求栏必须加两条——不出现疗效承诺表述、价格与适用范围表述与上架信息一致。

什么情形下不灵：引流款选品选错（拿高风险、高决策成本的项目做引流，比如直接拿种植做超低价引流），到店客的预期和机构能给的体验错位，转化率怎么都起不来。选品是运营与医生一起定的判断，AI 只执行文案。

6.2 医疗类目开店：资质是门票，规则卡是日常

美团、抖音等本地生活平台的医疗健康类目有专门资质门槛：执业许可、医师资质备案等材料，入驻时一次备齐。两个容易吃亏的点：其一，材料里机构名称、地址、医师名单要和 5.3 节 GEO 布局的公开信息口径一致——一次核对，两处受益；其二，团购页面文案同样受广告合规约束，「最专业」「无痛保证」这类表述上了货架就是证据，发布前过一遍第 8 章的禁用词检查。

日常管理建「平台规则卡」：每平台一张卡片，记准入要求（资质材料清单）、内容限制（疗效表述/案例展示/价格表述的各自口径）、审核周期三栏，运营负责人维护，平台规则更新即更新。医疗类目的审核周期普遍比普通类目长——活动套餐的提审要按「审核周期加修改余量」倒排，压到活动前一天提审，驳回一次就错过整个档期。各平台医疗类目的规则差异大且持续收紧，凭记忆运营医疗类目，踩线的概率随时间只增不减。

什么情形下不灵：规则卡能管住已知规则，管不住平台突击调整。新活动上线前，把平台审核通过本身当作收口的一关，别拿「以前都这么发」当依据。

6.3 评价运营：邀评靠真实，回差评靠流程

评价是本地生活的命脉，也是 AI 回答引用的信息源（5.2 节）。两条纪律：

正当邀评。服务完成后自然邀请真实客户评价，禁止利益诱导（好评返现、送项目换好评）与任何形式的刷评。真实口碑慢，但它能过 AI 与平台的双重验证；刷来的口碑被识别一次，店在平台侧的权重损失远大于几条好评的收益。

合规回差评。差评回复是公开内容，每一条都可能被潜在客户和 AI 读到，回复质量按对外内容的标准管。AI 的用法是出初稿，三段式：承认感受、说明事实、给出解决路径。提示词：

```
【角色】你是机构负责客户关系的运营，风格诚恳、不辩解。
【任务】为下面这条差评写一段公开回复，100 字以内。
【背景】差评原文见分隔线内；机构核实的事实是：（填你方核实后的情况，如：当日确有排队超时/该表述与病历记录不一致等）；机构愿意提供的补救是：（填具体动作）。
【要求】1. 三段式：先承认客户的不佳感受，再陈述核实后的事实（不贬低客户、不指责同行），末尾给出具体解决路径与联系入口；2. 不出现「绝不」「保证」类绝对化表述；3. 不透露其他客户信息与诊疗细节；4. 语气克制，不用感叹号。
```

———
（粘贴差评原文）
———

AI 初稿之后必须由负责人改定稿：核实过的事实才写得，没核实的「当时情况」一个字都不能让 AI 补。差评回复写错事实，等于在公开场合留下第二处证据。

什么情形下不灵：差评涉及医疗争议或赔偿诉求时，回复文案不是运营单方能定的事——转医生与机构负责人评估，有些差评的正确动作是线下沟通，公开回复只留一句「已与您联系」。这一档 AI 退出，人接手。

6.4 私域分层：能线上说的和必须面诊说的

到店客户加微率的提升靠场景设计（服务完成时、复查提醒时自然添加），加进来之后的管理靠分层。按两个维度分：来源（科普内容/团购/老客转介绍）与阶段（未到店/已到店未成交/已成交）。

阶段 × 来源	科普内容进来	团购进来	转介绍进来
未到店	内容继续触达，邀约面诊	到店流程提醒，降低爽约	优先安排，报转介绍人
已到店未成交	医生方案异议跟进（第 7 章）	方案异议跟进	方案异议跟进
已成交	随访+复查提醒（7.5 节）	随访+复查提醒	随访+致谢转介绍人

AI 在私域的位置：打标签的初步整理、跟进节奏的排程提醒、各层通用话术的初稿。到店客户加微的场景挑三个最顺的：服务完成时（「复查提醒我发您微信上」）、复查提醒时（顺理成章的再次触点）、内容共鸣时（客户咨询里聊到某篇科普，顺势说「这篇是我写的，加微信发您完整版」）——三个场景的共同点是添加理由对客户有用，推销味的添加请求只会拉低通过率。医疗场景在这里有一条硬边界：**线上不诊断、不下方案、不报价目**——涉及个体判断的内容（你适不适合、需要做什么、大概多少钱）一律留到面诊，由医生说。这条边界写进全部私域话术的「要求」栏，机构口径统一。

边界为什么也是效率：把专业判断留在医生手里，客户得到的答案一致、专业、可负责，信任积累反而更快；咨询师线上越界给方案，给错了要返工，给对了也抢了面诊的价值——面诊没理由，到店率反而降。

什么情形下不灵：分层跟进话术对「沉默客户」容易变成骚扰。跟进节奏要有上限（比如未到店客户两周内不超过三次触达），超限就停——触达频率是人的判断，AI 排程排不出「该停」。

6.5 复购与转介绍：老客的第二次价值

第 3 章立过账：私域的意义在于老客的获客成本远低于拉新。落成动作是两件：

复购。术后随访（7.5 节的方法）、按项目周期的复查提醒、基于就诊记录的个性化提醒（比如半年该洁牙了）。个性化提醒长什么样，拿洁牙举例：群发版是「洁牙建议每半年一次，欢迎预约」；个性化版是「您上次洁牙是三月，按周期这周到月底合适，医生上次提到您右下后牙区容易存软垢，这次可以重点处理」——第二版的每个信息点（时间、牙区、医生的提醒）都来自就诊记录。AI 排程，人做关怀——提醒的时机可以自动，提醒的措辞里「上次您说」必须是真的，这要求系统里有就诊记录，而不是群发模板。

转介绍。让老客愿意推荐的机制是「体验本身 + 分享便利」：做得好是前提，然后给一个顺手转发的理由（可分享的复查提醒卡、适合发给朋友的科普内容）。避免赤裸的利益换转发——「推荐一人返现」消耗的是老客的人情，人情用一次少一次。

什么情形下不灵：机构体验本身有硬伤时，复购和转介绍的所有技巧都是加速器反向使用——差体验加上跟进频率，只会让客户更快离开。这一章全部方法的前提是 6.1 那句判断成立：医生把人留下来。

动手练习

给你机构的团购套餐做一次「双层结构」审查并重写文案：

1. 列出你机构当前在架的全部套餐，按「引流款/利润款」归类——如果全是利润款没有引流款，或全是引流款没有利润款，先记下这个结构问题。
2. 选一个引流款，按 6.1 的算例填入你机构的真实数字（定价、成本、到店转化率——转化率不知道就先估一个并标注「待实测」），算出每个到店客的期望值。
3. 用四要素提示词让 AI 重写这个套餐的文案，「要求」栏写上：无疗效承诺、无绝对化表述、价格与适用范围与上架信息一致。
4. 对照 6.2 的口径给这条文案过一遍禁用词，拿不准的句子记下来，带到第 8 章。

思考题

1. 6.1 的算例里，转化率在净 141 元和净 21 元之间摆动（约 2.4% 处翻亏）。按你机构的真实情况估：引流款到店客户里，最终消费利润款的比例是多少？这个数在机构里有人盯吗？
2. 「线上不诊断、不下方案、不报价目」——翻你机构咨询师的聊天记录，找一条越界给了方案的消息。当时为什么越界？边界写进话术规范了吗？
3. 差评回复「没核实的事实一个字都不能让 AI 补」。如果你机构昨天收到一条与病历记录不符的差评，公开回复的三段式你会怎么写？先说感受还是先核实？

配图需求清单（工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 6-1	结构图	套餐双层结构：引流款（降门槛带人进店）→ 利润款（医	自绘

图号	类型	内容说明	来源建议
		生方案承接收入），标注转化率为翻转点	
图 6-2	算例图	引流款期望值算例：转化率 20%/10%/5% 三档的到店客期望值曲线，标注「假设参数」	自绘
图 6-3	流程图	差评回复三段式：承认感受 → 陈述核实事实 → 给出解决路径，AI 初稿 + 负责人定稿	自绘
图 6-4	矩阵图	私域分层矩阵：来源 × 阶段九宫格，各格标注跟进动作与沟通边界	自绘

第 7 章 咨询与转化：从留资到到店复购

本章导读

咨询师是消费医疗机构的人力成本大户，也是 AI 提效空间最大的岗位——不是替代咨询师，而是把人的时间从重复回复里解放出来，留给高意向客户。这一章给咨询全流程的 AI 助攻：留资线索的首次响应（速度是第一变量）、面诊前的需求预沟通（AI 说到哪一步为止）、异议处理与价格沟通的合规话术、术后随访的 AI 排程。章末给一张「AI 不接手清单」：价格承诺、效果承诺、风险告知，三样内容 AI 只能整理格式，定稿必须是人。

7.1 咨询的第一变量是速度，不是话术

同一条留资线索，两种接法。机构甲：咨询师在忙，线索躺了两小时，回复时客户已经问过两家同行，比价心态已成。机构乙：系统五秒内自动首响（回应问题、告知面诊价值），咨询师十五分钟内人工接管——客户还停在「想了解」的状态里，对话接得上。

判断是：**留资转化的第一变量是响应速度，话术是第二位的。**线索的「新鲜度」以分钟计：客户提交手机号的那个瞬间意愿最高，之后每过一小时都在降温。话术再好，接不上温度也是白写。

全流程五环节各有一个折损点，AI 的介入位置标在旁边：

环节	主要折损点	AI 介入位置
留资	响应慢，线索凉了	自动首响 + 人工接管的接力
邀约	约不到合适时段	时段提醒与改约话术参考
到店	爽约	到店前提醒（AI 排程）
成交	方案异议处理不当	异议处理参考话术（人取用）
随访	断联，复购无门	随访排程与提醒（7.5 节）

什么情形下不灵：线索质量极差时（错误号码、随手填表），响应再快也没有转化——速度解决「接得上」，解决不了「本来就不是客户」。对线索质量的过滤（来源结构分析）是运营的月度功课。

7.2 首次响应：自动首响兜底，人工接管收口

接力结构是关键：自动首响不是让 AI 聊完，是让线索在人工接上之前不凉。首响话术的骨架三件：回应客户问的那个问题（哪怕只回应「收到，这个问题很具体」）、体现专业性（一句话说明为什么需要面诊评估）、低压力邀约（给时段选项，不给成交压力）。

提示词骨架沿用第 2 章，「背景」栏喂客户来源——从科普文章进来的客户和从团购进来的客户，开场的关注点不同：

【角色】你是一家（口腔/医美）机构的咨询助理，负责留资线索的首次回复。
【任务】客户刚在线上留资，附言是「(填客户原话)」，写一段首次回复，80 字以内。
【背景】客户来源：(科普文章/团购套餐/老客转介绍)；机构规矩：线上不报价，方案以面诊为准；目标不是成交，是在 15 分钟内把对话转给咨询师并约到面诊。
【要求】1．先回应客户附言里的问题点；2．用一句话说明为什么需要面诊评估；3．结尾给两个可选到店时段，语气自然像人打字；4．不出现价格，不做任何效果承诺，不用感叹号。

这笔账值不值得上自动首响，用算例过一遍。**以下全部是假设参数：** 月留资 100 条，人工-only 模式下平均响应 3 小时、留资到到店转化 15%；加上自动首响后平均响应 5 分钟、转化升到 30%（响应速度对转化的提升幅度因机构而异，此组参数为演示假设，上线后用你自己的前后数据替换）。到店客按客单 2000 元、毛利 40% 计：转化 15% 时月毛利 12000 元，30% 时 24000 元——差额 12000 元/月，就是响应速度的价格。翻转参数：如果机构咨询师本来就不忙、每条线索都能人工秒回，自动首响的增量收益趋近于零，还要多承担一层「机器人感」的风险——**单量决定这道账站在哪边，线索量小的机构先把人工响应盯紧就够了。**

什么情形下不灵：自动首响模板长期不更新，客户一眼识破「机器人回复」，反而拉低信任。首响文案按月回看一次，像人打字的要求不能松。接力棒交接的质量也要管：自动首响转人工时，给咨询师一张三行信息卡——客户来源、客户问过什么、系统已答什么。缺这张卡，客户要对第二个人把情况重说一遍，「你这边怎么什么都不知道」的不耐烦，抵得掉首响抢回来的全部温度。

7.3 面诊前预沟通：收集信息，不给方案

预沟通的目的只有两个：收集信息（诉求、顾虑、基本情况），约下面诊。AI 能帮的：把客户零散的描述整理成结构化信息卡（主诉、既往情况、关注点），列一张面诊待确认清单给医生——医生接诊时省十分钟问诊，这就是 AI 在医疗流程里恰当的深度。

止步线必须划死：凡是涉及个体判断的内容——你适不适合做、需要做什么项目、大概要花多少——一律留到面诊，由医生说。这不是话术技巧问题，是边界问题：线上说得越满，面诊时翻车的落差越大；线上留白留得好，「面诊」本身就成了客户想要的东西。

什么情形下不灵：客户在线上反复追问方案细节、不约面诊时，咨询师容易为了「留住人」开始越界给方案。这一档的纪律是宁可放走，不给线上方案——被放走的客户下次可能回来，被错误方案留下的隐患落不到纸面上。

7.4 异议处理：回应顾虑，不碰三条红线

高频异议就四类：贵、怕疼、怕失败、要回去商量。应对的共同思路：把异议还原成客户的顾虑，回应顾虑本身，不绕开它。AI 的用法是给参考话术池，咨询师按客户语境取用改写，不是复制群发。

价格沟通的合规线单独列，因为踩的人最多：

- 不虚构原价（先涨后折的「原价」是价格违法的典型形态）；
- 不做「全网最低」类承诺（绝对化表述，第 8 章禁用词）；
- 不贬低同行报价（贬低同行既容易涉不正当竞争，也拉低自己的格调）；
- 效果与价格不绑定承诺（「保证做平」「无效退款」类话术是疗效承诺红线，第 8 章展开）。

异议处理的提示词把红线直接写进要求栏：

```
【角色】你是一位经验丰富的消费医疗机构咨询师主管。
【任务】客户说「(填异议原话，如：隔壁家比你们便宜三千)」，给 3 条应对话术，每条 60 字以内。
【背景】机构规矩：线上不报价目、不评价同行；该项目的成本构成是（填：耗材/医生资质/服务流程等，按机构实际)。
【要求】1．每条先复述客户的顾虑再回应，不回避价格问题；2．把对话引向「面诊后医生按情况给方案」；3．不虚构原价、不说「最低价」、不贬低同行、不做任何效果承诺；4．语气平实，不用感叹号。
```

什么情形下不灵：异议背后是真实预算约束时（客户就是只有那么多钱），话术解决不了预算问题——正确动作是如实说明什么项目在什么价位，让客户按预算选或回去考虑。硬话术推单，推来的是术后纠纷。

7.5 术后随访：AI 排程，人做关怀

随访是复购的入口（衔接 6.5），也是不良事件监测的日常落点（衔接第 9 章）。分工清楚：**节奏归 AI，温度归人**。AI 按项目周期生成随访计划——术后第 1 天、第 7 天、第 30 天、第 90 天各一次，到期推给咨询师；随访内容的措辞里，「上次您提到」这种个性化信息必须来自真实就诊记录，群发模板假装熟络，客户一眼识破。

随访话术的另一层纪律：随访中客户报告异常（持续疼痛、肿胀不退）时，第一动作是让医生介入，不是让咨询师用话术安抚。这条转接规则写进随访 SOP，比任何话术都重要。

什么情形下不灵：随访做成了推销（每次随访都带促销），客户学会不接电话。随访和营销在时间线上要分开——随访频次里纯关怀的比例过半，这条线才可持续。

7.6 AI 不接手清单：三样内容必须人定稿

全章收在一张清单上。三样内容，AI 可以整理格式、可以列要素，内容本身必须由医生或机构定稿：

不接手项	AI 能做的	定稿责任人	红线依据
价格承诺	整理报价要素、核对表述格式	机构（定价权在人）	价格表述涉价格违法风险
效果承诺	列告知要素清单	医生（医学判断在人）	疗效保证类表述是广告红线
风险告知	整理告知流程与签署格式	医生（术前告知必须医生完成）	知情同意是抽查必查项

这张清单落成制度：写进咨询团队工作规范，新人培训第一课，咨询师考核里放一票否决项。AI 不接手的不是能力不足，是责任归属——这三样的签字责任本来就落不到 AI 头上，落不进去的东西就不能让它写。

什么情形下不灵：没有制度兜底的清单只是墙上的纸。验证方法很简单：随机抽咨询师本周发给客户的十条消息，看三条红线内容的定稿人是谁——答不出「是谁定的」，清单就还没生效。

动手练习

用第 2 章四要素骨架，给你机构最常见的三类异议各写一条参考话术：

1. 从咨询记录里挑出出现频率最高的三条异议（大概率在 7.4 说的四类里）。
2. 按 7.4 的提示词骨架生成话术，「背景」栏填你机构的真实规矩与项目成本构成。
3. 对每条话术标注：哪一句是 AI 可以生成的，哪一句涉及三条红线之一必须人定稿——标不出来的那条，整条都不能用。
4. 把三条定稿话术存进提示词库咨询分区（2.4 节格式），并给团队定一条规则：参考话术取用后必须按客户语境改写，禁止原文群发。

思考题

1. 7.2 的算例里，响应速度的月度差额是 12000 元（假设参数）。把参数换成你机构的真实留资量与客单价重算——响应速度在你机构值多少钱？这笔钱现在有人认领吗？
2. 「线上留白留得好，面诊本身就成了客户想要的东西」——你认同这个逻辑吗？它和你机构咨询师当前的考核指标（比如线上成交率）冲突吗？冲突的话改哪个？
3. AI 不接手清单里三样内容，哪一样在你机构被踩得最多？抽十条最近的客户消息验证一下，定稿人是谁？

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 7-1	流程图	咨询五环节：留资 → 邀约 → 到店 → 成交 → 随访，标注各环节折损点与 AI 介入位置	自绘
图 7-2	接力图	首响接力结构：客户留资 → 5 秒自动首响 → 15 分钟人工接管，标注各棒职责	自绘
图 7-3	边界图	预沟通止步线：AI 与咨询师可做的（收集信息/约面诊）vs 必须留到面诊的（个体判断）	自绘
图 7-4	清单图	AI 不接手清单：价格承诺/效果承诺/风险告知三栏，各配定稿责任人与红线依据	自绘

第 8 章 医疗广告红线：一张审查证明管住全部内容

本章导读

这一章是全书与所有「AI 营销书」拉开距离的地方。制度底座：任何形式的医疗广告——含线上平台、小程序、公众号、短视频——发布前须取得《医疗广告审查证明》，未审先发即违法；虚假广告可处广告费 3-10 倍罚款，按海口清单引用的广告法罚则，金额可达 20-100 万（口径：海口市营商环境建设局 2026 年 7 月发布的行政合规指导清单）。这一章把 AI 生成内容与广告红线绑在一起讲：什么内容算广告、禁用词四分类、案例与对比照的边界、平台规则应对，收口成一张发布前检查清单。AI 产能越大，这张清单越重要。

8.1 科普还是广告，边界比多数机构想的窄

两篇种植牙科普，内容几乎一样。甲版本通篇讲流程、适应症、术后注意，文末没有机构与服务推介信息；乙版本同样内容，文末加了一句「我院进口种植体本月优惠」。前者有没有广告属性可以讨论，后者按海口清单口径就是医疗广告——发布前须取得《医疗广告审查证明》，未审先发即违法。**同一篇内容，加一句话就换了法律性质，而多数机构的内容流程里，根本没有「这句话触发审查」这个判断环节。**

判断是：**「科普」与「广告」的边界，以是否推介具体机构的服务为核心判断线，而不是以内容形态为线。**公众号长文可以是广告，团购页文案必然是广告，医生口播里的一句「来我们这做」也是广告。带着这个口径回看你机构的所有对外内容，第一件事是分堆：哪些已取证、哪些没取证、哪些根本没意识到自己算广告。

审查证明的实操口径：办理流程与时效各地有差异，本书给全国面上口径，机构应向当地卫健部门确认现行流程。落到流程上是两个动作：把「取证周期」写进内容排期（衔接 4.5 节，广告类内容的排期要比纯科普多留出取证时间）；把「哪些内容要证」的判断写进发布前检查清单（8.5 节），让流程替记忆把关。

什么情形下不灵：「是不是广告」的个案认定权在监管与执法环节，机构的自查判断只是风险控制手段，不构成豁免依据。拿不准的内容，宁按广告处理去取证，别按科普处理赌概率。

8.2 禁用词四分类：AI 最容易踩的坑，也是最值得流程防的坑

AI 写文案为什么天生爱踩禁用词？因为它读过的语料里，营销话术占了相当大的比例——「最安全」「保证有效」「领先同行」是训练文本里的高频搭配。第 2 章把合规约束预埋进提示词，能降低概率，清不了零。所以禁用词检查必须是独立的发布前工序，不寄望于提示词一步到位。

四分类框架，逐类给识别要点：

分类	典型表述	识别要点	替换思路
绝对化	最安全、第一、唯一、独家技术	凡「最/第一/唯一/绝对」开头的评价	改为可核查的具体事实（做了什么、怎么做的）
疗效保证	保证有效、根治、无效退款、包满意	凡对结果下保证的表述	改为「因人而异、以面诊评估为准」的限定表达
夸大对比	领先同行、超越同类、别人做不了的我们能做	凡拿同行作比较的评价	删掉比较，只讲自己的流程与资质
诱导促销	限时抢购、最后 X 个名额、错过再等一年	凡制造稀缺紧迫的医疗促销话术	医疗服务促销按当地口径从严，能不蹭就不蹭

AI 自查的用法：把成稿贴进去，让 AI 按四分类逐句标红，人复核标红结果并通读全文。提示词：

【角色】你是一家医疗机构的合规审核助理。
【任务】对下面这篇待发布内容逐句检查，按四类禁用表述标红：绝对化表述、疗效保证类、夸大对比类、诱导促销类。
【背景】内容类型：（科普文章/团购页文案/短视频口播稿）；发布平台：（填平台）。
【要求】1．逐句检查，输出的每条标红注明：原句、所属分类、修改建议；2．没有问题的句子不要标注，不要为了显得认真而扩大打击面；3．对「拿不准」的句子单独列一节，说明拿不准的原因，不要替人下结论；4．不新增内容，只做检查。
————
（粘贴待发布内容全文）
————

「拿不准单独列」这条要求很重要：AI 检查的价值是提效初筛，不是替机构下合规结论——它标红漏了的，人复核要兜底；它没把握的，恰恰是人工要重点看的。

什么情形下不灵：禁用词检查管「词」，管不了「结构性违规」——通篇没有一个禁用词、但整体构成未审先发广告的内容，这个词级检查拦不住。词级检查之上必须叠 8.1 的定性判断和 8.5 的清单，三层各管一段。

8.3 案例与对比照：真实性、授权、个体差异三道关

before/after 对比照与患者案例是医疗广告的高风险区，也是转化力最强的内容形态——正因为强，管得最严。三道关：

真实性关。 案例必须真实发生、素材未修饰、过程可溯。一条红线中的红线：**AI 生成或 AI 修饰过的图像，禁止对外充当真实案例。**「AI 美化过的术后照」不是摄影问题，是虚假宣传证据——哪怕效果描述是真的，图不是真的，整条内容就是假的。

授权关。患者肖像与病历信息用于对外内容，须有书面授权，授权范围（平台、期限）与实际使用一致。口头同意不算数，迎检时拿不出授权书等于没有授权。

个体差异关。「个体效果有差异」是必须如实表达的医学事实，不是免责套话。两者的区别在写法：免责套话是「效果因人而异」一笔带过、图照旧暗示人人如此；医学事实的表达是正视差异——展示的案例配什么条件（年龄、基础状况、治疗周期），说清这个结果是在什么条件下发生的。套话防不了投诉，事实才能防。

什么情形下不灵：案例内容哪怕三关全过，平台审核仍有独立的裁量口径——同一张图这个平台能发、那个平台驳回是常态。案例内容的发布计划要为平台驳回留时间，别把转化素材压到活动前一天才提审。

8.4 平台医疗类目规则：共性从严，差异建卡

主流内容与本地生活平台对医疗类目的规则，共性三条：准入要资质（机构认证、医师认证，材料见 11.5 节）、内容有限制（疗效表述、案例展示、价格表述各有口径）、审核有周期（医疗内容普遍比普通内容慢）。差异在执行：同一表述各平台松紧不同，且规则持续更新。

应对方法就是 6.2 节引入的「平台规则卡」：每平台一张，记准入要求、内容限制、审核周期三栏，运营负责人维护，平台规则更新即更新。发布前对照卡片过一遍——规则卡的本质是把「凭记忆运营」换成「凭卡片运营」，记忆会错，卡片错了能查到哪天改的。

什么情形下不灵：规则卡是运营侧的工具，平台审核驳回时的申诉沟通要人来处理——驳回理由读透、按平台口径改，这一档没有自动化捷径。

8.5 发布前检查清单：流程防错，不靠自觉

把全章收进一张可贴墙的清单。AI 产能越大，这张清单的机械执行越重要——**流程防错的原理是让每篇内容走同样的关卡，不依赖任何人的记忆和自觉。**

#	检查项	查什么	谁负责	不通过怎么办
1	广告定性	内容是否推介本机构服务；推介类是否已取证或排期取证	运营	停发，先进取证流程
2	禁用词四分类	按 8.2 表逐类自查，AI 标红 + 人复核	运营初筛、医生复核	删改后重过

#	检查项	查什么	谁负责	不通过怎么办
3	案例合规	真实性、授权书、个体差异表达三道关	医生	换素材或撤稿
4	平台规则	对照该平台规则卡逐项核对	运营	按平台口径改写
5	数字与引用	所有数字、法规引用有出处（第 2 章幻觉防线）	医生	无出处即删
6	署名定稿	医生审签完成，责任到人	医生	未签不发

清单的接口在两处：向上接第 4 章内容流水线——「医生改稿」环节即执行本清单；向下接第 10 章迎检——发布记录、审查证明、授权书按档案归存，抽查时拿得出来。

这道账放到本节收尾算一遍，回答「值不值」。**以下全部是假设参数：** 机构年广告投放 12 万元；若发生一次虚假广告认定，按海口清单引用罚则的最低档 3 倍计罚 36 万元；被查处概率假设 10%/年——期望损失 3.6 万元/年。合规流程的成本：运营自查加医生复核每月约 6 小时，按综合时薪 100 元计，约 7200 元/年。合规流程便宜约 5 倍。翻转参数：如果清单只是贴在墙上、执行形同虚设——人力照花、风险照担——机构进入最贵的「假合规」状态。**这道账最怕的不是合规贵，是合规假。** 判断流程真假的方法就是第 6 项的抽查：随机抽本周发布的内容，能逐条对上检查记录的是真流程。

什么情形下不灵：清单管得住机构自有内容，管不住全员的自发行为（医生个人账号发的内容，见第 11 章；员工朋友圈转发，见第 12 章培训议题）。清单的适用范围要在培训里讲明，别让团队以为「合规是市场部的事」。

动手练习

拿你机构最近发布的一条内容（公众号文章或团购页），全流程自查一遍：

1. 按 8.1 的口径先定性：这条内容推介本机构服务吗？拿取证照了吗？没取证的，记下「待取证」并排进内容排期。
2. 把全文贴进 8.2 的 AI 自查提示词，核对它标红的每一条，再通读一遍找漏网的——特别留意「保证」「专业」「领先」的变体句式。
3. 若含案例或对比照，核对授权书是否在档、授权范围是否覆盖发布平台。
4. 按 8.5 清单六项逐项打勾，把不通过项连同处置结果记成一份检查记录——这份记录本身就是 10.5 节迎检档案的一部分。

思考题

1. 回看你机构目前对外发布的全部内容渠道（公众号、团购页、短视频、医生账号）：哪些拿到了审查证明，哪些没有？没取证的那些，按 8.1 的定性口径算不算广告？
2. 8.5 的算例里最贵的状态是「假合规」——人力花了、清单没真执行。用什么机制能发现清单已经假了？（提示：第 6 项的抽查，由谁来做、多久做一次？）
3. 「个体效果有差异」是医学事实不是免责套话——从你机构的内容里找一条案例展示，判断它的差异表达是哪一种。如果是套话，改写成事实表达要补哪些信息？

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 8-1	流程图	医疗广告合规全流程：内容生产 → 广告定性 → 审查证明 → 禁用词自查 → 案例三关 → 平台规则对照 → 发布 → 归档	自绘
图 8-2	表格图	禁用词四分类表：绝对化/疗效保证/夸大对比/诱导促销，各配典型表述与替换思路	自绘
图 8-3	边界图	科普与广告的定性判断线：「是否推介具体机构服务」，两侧各配一个内容示例	自绘
图 8-4	清单图	发布前检查清单六项（贴墙版）：检查项/查什么/谁负责/不通过处置	自绘

第 9 章 药械、集采与追溯：合规的硬底盘

本章导读

药械合规是监管抽查的必查项，也是口腔机构受集采冲击最直接的地方。制度底座：医疗器械购、验、存、用全链条自查与追溯记录（UDI 全程追溯）；《医疗器械监督管理条例》（2024 修订）罚则最高 5-20 倍货值罚款；种植体集采中选产品纳入省级重点监管目录（口径：调研卡政策面，2026）。这一章讲数字化应对：进货查验与索证索票的电子台账、UDI 追溯记录怎么做才经得起查、集采后种植项目的价格与质量表达、耗材效期与不良事件监测的日常化。

9.1 台账拼的不是态度，是记录能不能当场对上实物

检查现场常见两种局面。检查组问「这批种植体的进货来源」，甲机构当场调出电子台账：供应商资质、注册证、进货查验记录、验收人签字，十分钟答完；乙机构翻纸质单据，验收单压在库房角落的文件夹里，批次对不上、签字不全，检查组按「进货查验记录不全」记录在案。**两家机构的合规义务一模一样，差别只在记录的组织方式——药械合规拼的不是态度，是记录与实物当场对得上的能力。**

判断是：**台账不是写给检查看的，是机构自己的免责证据。**进货查验、索证索票的记录义务，在出纠纷时（患者质疑耗材来源、供应商断联追责）是机构自证清白的凭据——平时不记，用时没有。

四环节各自的合规动作：

环节	合规动作	记录留什么
购	供应商资质与产品注册证核验，从正规渠道采购	供应商证照、注册证复印件
验	进货查验、索证索票（潜江培训会讲的就是这两件事）	查验记录：名称、规格、数量、批号、日期、验收人
存	贮存条件达标、效期管理	贮存环境记录、效期台账
用	使用登记与追溯关联	使用记录：患者、批次、UDI 码

电子台账的落地：诊所 SaaS 或电子表格均可，关键两条——字段完整、每笔必记。AI 在台账上的位置是整理与提醒（补录催办、字段缺失提示），不是替代记录义务：验收人签字、实物核对这些动作必须人在现场做。

什么情形下不灵：台账再全，供应商源头造假（资质伪造、货证不符）机构侧查不出来。对供应商的准入审核是台账之前的一道人关，AI 代替不了对渠道的判断。准入审核的具体动作三步：供应商证照齐全并核对发证机关；产品注册证在有效期内、型号与采购一致；首次合作前核对其经营资质与授权链（生产商授权或经销商层层授权）。这三步做完，把合格供应商名单固化成一张表，采购只从名单里走——名单之外临时补货，是台账断链的常见起点。

9.2 UDI 追溯：一条记录链经得起倒查

UDI（医疗器械唯一标识）是每件医疗器械的「身份证号码」。对口腔机构，重点是种植体：集采中选产品纳入省级重点监管目录，意味着种植体的追溯是重点中的重点——检查组查种植体，大概率按 UDI 链条倒查。

经得起查的记录链，拿一支种植体从入库到用进患者嘴里的完整路径举例：

链节点	记什么	对上的东西
入库验收	批号、UDI 码、数量、验收日期与签字	供应商随货同行单、注册证
贮存	贮存位置、温湿度记录、效期	库房环境记录
领用	领用时间、领用人、对应手术安排	手术排程
使用	患者、植入牙位、批次与 UDI 码、术者	患者病历、手术记录

经得起查的标准三条：**记录与实物对得上**（账面数量等于库房实数加已用量）、**时间链完整**（入库到使用的每一步有时间戳、不断链）、**可倒查**（任拿一位患者的种植体，能在十分钟内倒查回入库批次）。检查现场的从容，来自平时这三条的机械执行。

AI 辅助的做法：用 AI 核对记录链的完整性——把台账数据贴给它，让它查断链和缺字段：

```
【角色】你是一家口腔机构的质控助理。
【任务】检查下面这份种植体追溯记录的完整性，找出断链与缺失。
【背景】记录字段包括：入库日期/批号/UDI 码/数量/验收人、领用时间/领用人、使用患者/牙位/术者（见分隔线内的表格数据）。
【要求】1. 逐行核对：哪些记录缺字段（如缺验收人签字、缺 UDI 码）；2. 数量核对：入库总数减领用总数是否等于在库数，列出不平的批次；3. 只基于我给的数据检查，缺什么直接说缺什么，不要推测原因、不要编造数据补齐；4. 用表格输出问题清单。
————
（粘贴台账数据）
————
```

什么情形下不灵：AI 核的是记录内部的一致性，核不了记录与实物的一致——库房盘点（账实核对）必须人到现场，这一档永远归人。

9.3 集采之后：价格透明化，价值往技术与劳务上落

集采把种植体价格打透明了，患者拿着 7000 元上下的均价来对比，机构的价格口径必须经得起比。表达上有两条禁忌：不贬低集采产品（「集采的都是低配」这类话既得罪事实也踩 8.2 夸大对比类禁用语），不虚构「进口更高级」的话术给涨价找理由。

技耗分离的逻辑下，机构价值要往两处落：**技术**——医生的资质、方案设计能力、复杂情况的处理经验；**服务**——术前评估的完整度、术后随访的保障（这套随访能力恰好是 7.5 节建起来的）。价格表里把「耗材费」和「医疗服务费」分开呈现，患者看得懂钱花在哪，机构的价值主张也自然立住。对价格敏感的客户，如实说明不同价位对应的耗材与服务差异，让客户按预算选——集采把价格打透明的时代，坦诚本身就是竞争力。

什么情形下不灵：医生团队资质单薄的机构，价值落点无处可落——价格话术解决不了能力问题。这一档的正确动作是先补能力（人员资质自查见 10.2），再谈价值表达。

9.4 效期、库存与不良事件监测：省钱的合规

效期与库存管理是「合规动作顺便省钱」的典型。**以下全部是假设参数，用于演示算法**：一家机构年耗材库存周转 20 万元，效期管理粗放导致年过期报废 2%，即 4000 元净损失；上一个效期预警机制（AI 按月扫台账、按效期排序提醒「近三个月到期」清单），投入约每月 1 小时人力，按 60 元/时计年成本 720 元，报废率降到 1% 即省 2000 元——净收益约 1280 元/年。翻转参数：如果机构库存周转只有 3 万元，报废率即便从 2% 降到 1%，省下的 300 元也抵不上 720 元的投入——这道账直接为负。**小库存机构用手工月检就够了，别为小钱上系统；库存量越大，这道账越倾斜向自动化**。参数换成你自己机构的库存额和报废率，决定权在账上。

不良事件监测是另一个日常化的义务链：收集（患者随访中的异常反馈，衔接 7.5 节的随访转接规则）、记录（事件登记：时间、涉及耗材批号、情况描述、处置）、按监管口径报告。汕头培训会把「不良事件监测」与采购验收、贮存、使用登记并列为培训主题——监管反复教的位置，就是检查常看的位置。

什么情形下不灵：不良事件的判断（是否构成须上报的医疗器械不良事件）是专业判断，收集与记录可以流程化，判定与报告的口径要医生或质控负责人把关——AI 整理得了记录，担不了判定责任。

9.5 台账工具怎么选：账跟着采购笔数走

电子台账用什么载体，是这一章被问得最多的问题。用算例回答。**以下全部是假设参数，用于演示算法**：设一家店月均耗材采购 N 笔；表格方案每笔录入加索证归档按 5 分钟

计，质控时薪 80 元，月成本约 6.7N 元；SaaS 方案扫码入库加核对按 1.5 分钟/笔计约 2N 元，加 SaaS 年费按每店 3000 元估（每月约 250 元），合计约 2N+250 元。两式相等在 N 约 54 笔——**月均采购 50 笔以上的店，SaaS 开始反超表格；以下的店，表格加月检足够**。单店月采购十几笔的机构上 SaaS，买的不是效率是焦虑；连锁十家店每家 80 笔，表格方案每店每月约 530 元、SaaS 约 410 元，一家店一年省一千多元，十家店再加上数据总部可见的治理价值，账就完全倒向另一边。工具跟着采购笔数走，不跟着「别的机构都上了」走。

工具选型之外还有一条纪律不分档：**无论表格还是 SaaS，字段结构按 9.1 的四环设计，别迁就工具的默认模板**。检查组按四环查记录，机构按工具模板存记录，两套结构对不上，迎检时就要现场翻译——翻译不出就是记录不全。

什么情形下不灵：SaaS 的扫码入库依赖耗材带码可扫——部分耗材包装无码或码损，扫码率上不去时，SaaS 的效率优势缩水，混合方案（可扫的扫、不可扫的手录）是常态，别追求百分之百扫码的干净数据。

动手练习

用 AI 帮你做一次种植体追溯链的完整性核查：

1. 把你机构现行台账（电子表格即可）里最近一个批次的记录导出，按 9.2 的四链节点核对字段：入库、贮存、领用、使用，缺哪栏记哪栏。
2. 把数据贴进 9.2 的提示词，让 AI 查缺字段与数量不平——它的输出只是线索，每个问题项要人工到现场确认（账实核对归人）。
3. 列出缺失字段清单，按「补制度（字段没要求）」和「补执行（有要求没执行）」分两列——执行类的每一项写上责任人和补录期限。
4. 把效期管理的账算一遍：用你机构的年库存额与过期报废率代入 9.4 的算例，判断你站在账的哪一侧，再决定上不上自动预警。

思考题

1. 检查组现场抽一位三个月前做过种植的患者，要求十分钟内倒查到入库批次——你机构现在能做到吗？卡在哪一环？
2. 9.4 的效期算例里，库存规模决定这道账站哪边。用你机构的真实库存额代入，结论是什么？如果结论是「手工月检就够」，你打算用什么机制保证月检不漏？
3. 技耗分离后，机构价值要落在技术与劳务上表达。翻你机构的种植项目价格表和对外介绍：现在是耗材导向还是技术导向？如果换成技术导向，第一句会写什么？

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 9-1	流程图	购验存用四环节：各环节合规动作与记录	自绘

图号	类型	内容说明	来源建议
		要求，标注「每笔必记」	
图 9-2	链条图	种植体 UDI 记录链示例：入库验收 → 贮存 → 领用 → 使用，各节点记录字段与对上的单据	自绘
图 9-3	结构图	技耗分离价格表达：耗材费与医疗服务费分列，价值落点在技术与服务	自绘
图 9-4	算例图	效期预警算例：库存 20 万/3 万两档的净收益对比，标注翻转点与「假设参数」	自绘

第 10 章 资质与迎检：50% 抽查怎么应对

本章导读

抽查密度 50% 意味着每家医美机构两年内大概率被查一次——迎检的胜负在检查组进门之前就定了。这一章把迎检从「被动挨查」翻成「日常达标」：机构资质、人员资质、知情同意与病历、药械管理四块的自查动作；再用 2026 年监管侧的一串动作反推准备重点——诸暨「五个一」（78 家机构参加、61 起违法案例以案释法）、潜江约谈培训、汕头器械专项培训、福鼎告诫会、宝安科普合规基地。监管在教什么，机构就该把什么做扎实。AI 的位置：自查清单生成、培训材料整理、迎检资料归档。

10.1 迎检是翻平时的作业本，不是突击战

两家机构同月被抽中。甲机构按季度自查的档案体系，两天内备齐五类档案，检查现场按索引调材料，半天结束；乙机构接到通知才开始补材料——补记录、补签字、补授权书，越补越乱，而补出来的东西本身就是风险信号：补签的日期经不起核对，成套的「新」记录反而引出更多问题。

判断是：**迎检能力是平时达标能力的自然输出**。50% 的抽查密度下，「什么时候查到我」不由你定，能定的只有「查到我时家里是什么样子」。突击补材料这件事，要在机构内部明令禁止——它不仅是效率问题，补造记录的性质比记录不全更重。

按《2026 年国家随机监督抽查计划》（国疾控综监督二函〔2026〕63 号，2026-03-19 三部门联合印发）的口径，医美机构查四样：机构和人员资质、药械管理、医美广告发布、知情同意；口腔医疗机构列入医疗卫生抽查对象。四样分别对应本书第 10 章（本章）、第 9 章、第 8 章、10.3 节——合规线三章在这里汇合：**抽查的四查，就是前三章的清单按检查视角重新排列**。

什么情形下不灵：日常达标能覆盖常规检查项目，覆盖不了突发专项（某类器械专项整治、某类广告专项执法）。专项检查前监管通常有培训或通知信号（第 1 章那五场地方动作就是信号源），盯住信号、按专项口径加查，是日常达标之外的机动动作。

10.2 机构资质与人员资质：逐人核对，不留「大概没问题」

机构侧自查按海口清单的维度走：执业许可在有效期内、备案事项变更及时、价格公示上墙且与实际收费一致。证照建一张有效期台账，到期前 90 天提醒——AI 做到期提醒是它在这章最没争议的位置。

人员侧是这节的重点，也是最容易「大概没问题」的地方。医美主诊医师有法定条件（海口清单口径）：美容外科 6 年、美容牙科 5 年相关临床经历，加培训合格。这不是内部约定，是法定条件；机构里坐诊的人资质不够，查到是机构的责任。自查动作是逐人核对，建人员资质档案：

核对项	查什么	常见问题
执业注册	注册地与执业地点一致	多点执业未备案
主诊条件	临床年限与培训合格证明	年限按「从业」混算「注册后」
执业范围	所做项目在注册范围内	跨范围开展项目
证件有效期	执业证、培训证书在效期内	证书过期未续

口腔机构同口径自查医师资质。逐人核对的意思是：负责人现在就能说出每位主诊医师的资质状态，说不出就是没核对过。核对的频率跟着证件走而不是跟着感觉走——新员工入职核一次、每次续期注册核一次、每年资质台账例行核一次，三个节点卡住，人员资质这块就不会有意外。

什么情形下不灵：人员资质自查只能核「纸面条件」，核不了实际执业行为与注册范围的一致性——日常排班与手术安排是谁排的，谁就负有「安排资质匹配的人做匹配的事」的责任。排班岗要能看到资质台账，这是组织问题，不是文书问题。

10.3 知情同意与病历：告知是医生的事，整理可以是 AI 的事

知情同意的合规要点三条：术前告知到位（风险、替代方案、预期效果的表达留有分寸）、书面签署完整（同意书签署时间在操作之前、签字齐全）、过程留痕（告知过程在病历中有记录）。病历文书的完整性与诊疗记录规范是抽查的传统项目，四查之一。

AI 在这节的边界划得最清楚：AI 可以帮整理同意书模板的格式要素、可以把归档材料按患者和日期分类、可以在自查时核对「这份病历有没有漏签署页」这类完整性问题；**告知的内容与签署的过程必须医生完成**——知情同意的法律效力建立在医生与患者的真实沟通上，模板再全也代替不了沟通本身。这条边界与 7.6 节「AI 不接手清单」里的风险告知同源：凡是落在患者身上的判断与告知，责任在人。

什么情形下不灵：病历完整性核查的 AI 用法依赖电子病历系统——纸质病历为主的机构，先做电子化归档再谈智能核查，顺序不能反。电子化之外，病历自查人工做两件事就够用：每季度随机抽 10 份已结诊病历，核对「同意书签署时间是否在操作之前、签字是否齐全、告知过程有无记录」三处；再核一遍签署时间轴——补签的病历在时间轴上最露马脚，发现问题按 10.5 的整改流程处理，不私下补。

10.4 监管在教什么：五场动作反推检查重点

2026 年监管侧的动作密集且主题清晰，把五场放在一起看，监管的优先级一目了然：

时间	地方动作	主题	反推的机构自查重点
2026-01	深圳宝安合规培训，区妇幼保健院设「医美科普合规基地」	合规经营、科普合规	对外科普内容的合规（衔接第 8 章）
2026-07	诸暨「五个一」专项行动：自查自纠、业务培训、现场指导、信息查询平台、业务指导体系；78 家机构参加	自查自纠居首，61 起违法案例以案释法	按案例类型对号入座：61 起案例分布在哪类违法，自查就先查哪类
2026-08	福鼎行业告诫会加合规培训（51 家机构负责人）	行业告诫	告诫会点名的共性问题，就是本区域的检查倾向
2026-09	汕头医美器械质量安全法规培训（100 余人）	采购验收、贮存、使用登记、不良事件监测；要求「全员内部传达+培训记录」	器械四环节记录（第 9 章）；内部培训记录
2026-10	潜江约谈暨合规培训（70 余人）	进货查验、索证索票、以案释法	进货查验台账（第 9 章）

五场合起来的读法：**监管反复教的位置，就是检查频率最高的位置**。培训全是政府组织、免费参加——免费的课密集开，说明检查不是虚张声势（第 1 章立过这个判断）。机构的动作链：派人去听 → 回来内化成机构培训材料 → 全员传达 → 记录留痕（衔接 12.2 节）。诸暨「五个一」里「自查自纠」排第一位，监管把自查自纠当作行业改善的第一机制——机构主动整改的记录，在检查现场是加分项。

什么情形下不灵：以案释法的案例是「已查处」的样本，分布有滞后性——它反映监管在查什么，不完全等于下季度查什么。案例对号入座自查之外，对本机构独有风险（特殊项目、特殊人群）要自己加查。

10.5 季度自查节拍：档案五类，AI 归档

把达标机制落成节拍：**每季度做一次全机构自查**——按四查清单过一遍，问题项限期整改并留整改记录，下季度复查上季度的问题项。迎检资料按五类档案常备：证照档案（机构+人员）、药械档案（台账+追溯链）、广告档案（审查证明+发布记录）、同意书档案（签署+病历索引）、培训档案（记录+考核）。

AI 在归档环节的用法，一条提示词就能起步：

【角色】你是一家医疗机构的质控助理。
【任务】帮我生成本季度的合规自查工作底稿：按「机构资质/人员资质/药械管理/广告发布/知情同意」五个维度，各列出 5 个检查项。
【背景】本机构是（口腔诊所/医美机构），（有/无）医美科目；上一季度自查的待整改项是：

（粘贴上季问题项）。
【要求】1．每个检查项写明：查什么、对应什么凭证材料；2．上一季度的待整改项必须出现在本季清单里，标注「复查」；3．只生成检查项清单，不编造法规条款号；4．用表格输出。

生成的是底稿，逐项人工核对后才是自查记录——AI 提效率，自查结论的责任在质控负责人。

什么情形下不灵：季度自查最大的敌人不是流程设计，是执行松懈——前两季度全过，第三季度就开始走过场。防松的机制有三道：自查结果与岗位考核挂钩（衔接 12 章）；问题项「复查必带」的硬规则——清单里永远留着上季的旧账，走过场立刻可见；自查会由机构负责人主持而不是质控自转——负责人在场，走场的成本立刻高起来。三道里至少落实两道，这个节拍才守得住。

动手练习

给你机构做一次完整自查：

1. 按 10.5 的提示词生成自查底稿（记住把上季问题项喂进去——没有上季记录的话，这本身就是第一个发现）。
2. 逐项人工核对，结果分「合格项/待整改项」两列，待整改项标注责任人与期限。
3. 人员资质块按 10.2 的表逐人过一遍，现场回答一个问题：你能不能立刻说出每位主诊医师的资质状态？
4. 把自查记录连同五类档案的缺项清单存档——缺的档案就是本季度的补建任务，别留到接到检查通知那天。

思考题

1. 「补出来的材料本身就是风险信号」——你机构的合规记录里，有没有哪部分是接到检查通知后才补的？这部分的真实状态怎么补回来？
2. 10.4 的五场培训对照表里，你机构所在地区今年有没有类似动作？去听的培训回来内化成机构培训记录了吗——还是听完就散了？
3. 季度自查的执行松懈靠什么防？如果你是机构负责人，你会把自查结果和什么挂钩，才能保证第三季度不像走过场？

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 10-1	清单图	抽查四查自查总表：资质/药械/广告/知情同意，各配检查动作与对应章节	自绘
图 10-2	时间线图	2026 地方监管动作与主题对照（宝安/诸暨/福鼎/汕头/潜	自绘

图号	类型	内容说明	来源建议
		江），标注「反推自查重点」	
图 10-3	流程图	季度自查节拍：自查 → 整改 → 复查 → 归档，标注「复查必带」与 AI 辅助位置	自绘
图 10-4	档案图	五类迎检档案：证照/药械/广告/同意书/培训，各列必存材料清单	自绘

第 11 章 医生个人 IP：主治医师的安全做号法

本章导读

医生个人 IP 是消费医疗获客里信任浓度最高的一条路，也是资质与合规最容易翻车的一条路：头衔写错是资质违规，案例发出去是广告问题，科普写成带货是平台违规。这一章讲主治医师怎么安全做自媒体：定位选科普型而非营销型、AI 辅助生产（医生的投入压到每条 15-30 分钟）、资质与头衔的展示边界、平台医生认证的材料清单与常见驳回原因、机构号与医生号的协同分工。医疗内容平台对医生认证的要求逐年收紧，这章的材料清单一次备齐，避免反复驳回。

11.1 信任前置：IP 改变的是获客成本的结构

两位资历相当的种植医生，获客路径不同。甲的患者全部来自平台投放，每一位到店客都要从零建立信任——广告说服「这家机构可以试」，面诊从头讲「你是谁」。乙经营着科普账号，患者带着看了几个月内容的信任到店，面诊像回访——「你是谁」这个问题，账号早回答了。

判断是：**医生 IP 的价值不在流量，在把信任从到店后挪到到店前——获客成本的结构因此改变**。第 3 章立过账：到店转化损耗是获客四处成本里最疼的折损；信任前置的客户，异议少、决策快、折损小。转化逻辑的差异一句话：广告买来的是「试试看」的到店，IP 积累的是「就找你」的到店。

但这枚硬币有背面：**信任也是责任放大器**。账号里说的每句话，粉丝会当真、会照做、会拿着来面诊对质。机构广告说错话是营销事故，医生账号说错话是专业事故——这就是本章后半部分全是边界条款的原因。

什么情形下不灵：医生 IP 不是所有医生的杠杆。不擅长表达、没有内容时间、执业项目公众关注度低的医生，投入产出的账算不下来——IP 是长跑，用 11.3 的流水线把医生时间压到最低之后仍然挤不出时间的，别硬做，把 11.6 的机构号协同做好就够。

11.2 定位先选科普型：三栏内容框架，营销有一成上限

做号的第一道选择：营销型还是科普型。营销型账号涨粉快、死得也快——内容全是项目与优惠，粉丝没有留下来的理由，还持续踩广告红线。科普型账号慢，但每一篇内容都在积累同一笔资产：患者对「这位医生懂」的确认。

科普型定位的栏目框架，三栏配比：

栏目	内容	占比参考（假设经验值）	作用
患者问题科普	高频问题的医生解答	主力，约七成	建立专业信任
诊疗过程透明化	流程展示、术前检查讲解放大	约两成	降低到店心理门槛
医生日常与观点	出诊见闻、行业观察、个人立场	约一成	人格温度

营销内容（项目推介、活动信息）的上限设在一成，并全部走机构号承接——医生号的营销浓度一旦上来，科普积累的信任开始折旧。

选题来源与第 4 章共用患者高频问题库，但医生视角有一个独占优势：患者问医生的问题和问咨询师的问题不一样——咨询师收到的多是价格与流程，医生诊室里听到的多是恐惧与纠结（「种植是不是很遭罪」「我这年纪还行不行」）。后一类问题做成内容，共情浓度高得多。让医生每次门诊后花两分钟，把当天被问到的「有情绪的问题」随手记进问题库。

什么情形下不灵：三栏框架是内容盘子的结构，不是教条——有的医生观点表达强、科普表达弱，人格栏比重可以上调，但科普主力栏塌了，账号就退化成个人生活号，获客价值归零。每季度复盘一次三栏的实际占比，别凭感觉。

11.3 AI 流水线：医生的时间压到每条 15-30 分钟

医生最稀缺的是时间，IP 生产必须用流水线把医生的投入切成一段：**医生只出口述素材——对着录音把一个问题的答案讲一遍，讲人话、讲诊室里讲的那版；AI 负责转写、整理、成稿；医生审签发布**。每条内容的医生投入：口述 10 分钟上下，审签 10-15 分钟，合计 15-30 分钟。

口述素材的转写整理提示词：

```
【角色】你是一位医疗科普内容编辑，服务对象是执业医师。
【任务】把下面这段医生的口述录音转写稿，整理成一条 60 秒短视频口播稿（250 字以内）和一篇 500 字图文稿。
【背景】医生身份：（科室、从业年限、资质按 11.4 的边界口径填写）；目标观众是（填人群，如 40–55 岁正畸犹豫人群）；这个问题的诊疗表述以口述为准，不得改写医学内容。
【要求】1. 医学表述、数据、限定词（一般/多数/少数）一律照口述原样保留，不许润色升级；2. 结构三段：患者的原话式问题开场 → 医生的解答 → 「具体以面诊为准」收尾；3. 不出现价格、机构推介、疗效承诺；4. 口播稿用短句，书面稿保留口述的口语感；5. 整理稿末尾单独列出「医生需复核的 3 处医学表述」。
————
```

（粘贴口述录音的转写文本）

——————

第 5 条要求是流水线的质量闸：让 AI 主动把需要医生复核的位置标出来，审签就不是通读全文，而是核对清单——这 10 分钟才压得下来。第 1 条「不许润色升级」是医疗场景特有的红线：通用写作里 AI 把口语改书面是加分项，医疗内容里改写医学表述是事故源。

什么情形下不灵：口述素材质量决定整条线——医生讲得含糊，AI 整理出来的就是含糊的书面语。口述环节给医生一个模板（问题是什么、患者怕什么、一句话结论、一个提醒），讲满四点，素材就够用。

11.4 资质展示边界：能写的要有证明，不能写的别碰

头衔与资质是医生账号的信任基石，也是监管与平台审查的第一落点。一句话判断标准：**写上去的每一项，都要能当场拿出证明材料**。 对照表：

能写（有证明）	不能写（无证明或违规）
执业医师资格、执业注册信息，如实写	虚构头衔、「特聘专家」类无法核实的名头
主诊医师资质，按法定条件对应表述（衔接 10.2）	借用机构资质夸个人（机构的技术说成个人独创）
学会任职、进修经历，附证明可查	跨执业范围的「专家」表述（种植医生讲正畸权威）
真实、授权、可溯的案例（第 8 章三道关）	无授权患者信息、修饰过的对比照

常见的翻车不是造假，是「顺手夸张」：把「参加某学术会议」写成「某学会委员」，把「进修学习」写成「师从某某」——每一步的夸张单看都不大，叠起来就是资质虚假表述。自查方法同前：逐项问「证明材料在哪」。

什么情形下不灵：资质表述的合规判断存在灰区（学会头衔的规范写法、进修经历的表述尺度），平台与监管的口径也可能更新。拿不准的表述，发之前问一句当地卫健或平台审核，比发了再删便宜。

11.5 平台医生认证：材料一次备齐，名称三处一致

主流内容平台的医生认证，材料清单大同小异：执业医师资格证、执业证、职称证明（如有）、机构任职证明，部分平台要求提交执业范围与发科目的对应说明。提交要点两条：材料清晰可辨（翻拍模糊是驳回的高频原因）、信息前后一致。

常见驳回原因按频率排：材料不清晰、名称不一致（认证提交的姓名/机构名与执业注册的不一致）、执业范围与申请认证的领域不符。其中「名称一致性」值得单独强调，因为它同时服务两处：**平台认证名称、执业注册名称、机构公示名称三处一致**——这既是平台审核的通过项，也是 5.3 节 GEO 资质件「AI 交叉验证」的加分项。一致性这一个动作，平台和 AI 两个审查方都认。

什么情形下不灵：认证通过不等于一劳永逸——平台会定期复核，执业信息变更（换机构、升级职称）要同步更新认证，拖着不改的账号在复核时掉认证，掉认证的历史内容还要重新评估。

11.6 机构号与医生号：一条生产线，两个出口

协同分工一句话：**机构号管资质与服务信息（GEO 的弹药，5.3 节三件套），医生号管信任与人格内容（本章流水线的产物）**。两个号互相导流的合规方式：医生号内容里自然提及出诊机构（与 8.1 的广告定性口径对照——推介性表述落在机构号或已取证的内容里）；机构号发布医生的专业内容并规范署名。别做的：机构号批量搬运医生内容不署名（人格资产被稀释，医生也没动力供内容），医生号挂机构营销活动不加区分（营销浓度超标，11.2 的一成上限被击穿）。

生产线的经济性在于两个出口共用一套流程：医生一次口述，AI 整理出短视频与图文两版，短视频发医生号，图文发机构号——内容产能不加倍，两个账号都有得发。连锁机构再加一层：总部把流水线做成标准模板，各店医生按模板供素材，内容治理权在总部。

什么情形下不灵：医生与机构的关系不稳定时（即将离职、多点执业），账号归属与粉丝资产的归属要先谈清楚再起号——账号用谁的实名、粉丝认的是谁，离场时都是纠纷源。这是商业协议问题，AI 和流程都解决不了，起号前人谈明白。

动手练习

录一段口述素材，把流水线完整跑一遍：

1. 医生从问题库里挑一个有情绪的问题（患者问的时候带着纠结的那种），用 11.3 的四点模板口述 5-10 分钟并录音转写。
2. 把转写文本贴进 11.3 的提示词，得到口播稿与图文稿两版。
3. 医生按「需复核的 3 处医学表述」清单审签，记录实际用时——这就是你机构这条流水线的真实单条成本。
4. 对成稿做三道边界自查：资质表述逐项能拿出证明吗？营销浓度超一成了吗？若含案例，第 8 章三道关过了吗？三道都过，再排发布。

思考题

1. 「信任前置改变获客成本的结构」——按第 3 章你算过的获客账：如果 IP 线带来的到店客转化损耗降一半，对你机构的利润意味着什么？这条线值得投入一个运营岗吗？
2. 「写上去的每一项，都要能当场拿出证明材料」——现在打开你（或你机构医生）的账号简介页，逐项过一遍：有几项拿不出证明？
3. 医生每条内容只投 15-30 分钟的设计，靠「AI 标出需复核处」把审签压到 10 分钟。如果医生不信任这个清单、坚持通读全文，流水线还成立吗——你的答案是什么？

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 11-1	结构图	科普型账号三栏框架：科普/透明化/人格，标注占比与「营销一成上限」	自绘
图 11-2	流程图	医生 IP 生产流水线：口述素材 → AI 转写整理（标出复核处）→ 医生审签 → 双出口发布（医生号+机构号），标注医生时间投入点	自绘
图 11-3	对照表	资质展示能写/不能写对照表，各配示例与判断标准「证明材料在哪」	自绘
图 11-4	示意图	名称三处一致：平台认证名 = 执业注册名 = 机构公示名，标注平台与 AI 双审查方	自绘

第 12 章 团队、培训与底线：把合规做成竞争力

本章导读

最后一章管两件事：把前面十一章的方法落成组织能力，把底线划清楚。组织侧：运营、咨询、合规三个岗位在 AI 时代的分工与提示词库归属、内部培训怎么做（汕头培训会要求的「全员内部传达+培训记录」就是机构自训义务）；人才侧：数字化岗位需求在涨（口腔数字化义齿设计岗位需求年增 35%、人才缺口 8 万，2025 口腔行业人才报告口径），机构怎么招、怎么养。底线侧：全书风险总盘点合成一张机构级检查清单。收在一句话：合规不是获客的对立面，把合规做扎实的机构，才拿得到 AI 增长的复利。

12.1 岗位不分清楚，AI 产能越大机构越乱

两家机构同时给全员开通 AI 工具。甲机构没划分工：文案谁都能发、话术谁都能编、清单谁都能出，三个月后一条没审过的推介内容换来一次整改——产能上去了，闸门没人管。乙机构先划岗位定稿权再放开工具：运营的内容过发布前检查，咨询的话术过不接手清单，合规的清单人工复核——同样的产能，零事故。

判断是：**AI 落地的第一步不是教大家怎么用，是划清谁对哪类内容的定稿负责**。定稿权不清，AI 只会把机构原有的混乱放大——它不制造风险，它加速一切，包括加速犯错。

三个岗位的分工表，与第 2.4 节的提示词库三分区一一对应：

岗位	管什么	提示词库分区	定稿权边界
运营	内容生产、GEO 布局、本地生活、评价运营	运营分区	对外内容经发布前检查（8.5）后发布
咨询	话术、跟进、随访执行	咨询分区	三条红线内容（7.6）必须人定稿
合规/质控	自查清单、药械台账、档案归档、培训记录	合规分区	检查清单结论与自查报告签字权

两个跨岗位交接点单独点名：内容流水线的「医生改稿 + 发布前检查」是运营与合规的交接（4.3 + 8.5）；咨询话术的「AI 不接手清单」是咨询与合规的交接（7.6）。交接点的意义是责任的接缝处——机构事故大多不是没人负责，是接缝处两边都以为对方在看。

什么情形下不灵：小机构一人多岗（老板兼运营、前台兼咨询），分工表照立——岗位可以合并，定稿权的边界不能合并。一人分饰三角时，每个角色的「帽子」换着戴：写的时候是运营，审的时候必须是合规，自己审自己是分工表明令禁止的。

12.2 培训记录就是合规资产：把监管的免费课变成机构的台账

汕头培训会的要求「全员内部传达+培训记录」，说的就是机构自训义务：监管的培训到场率再高，覆盖不了机构全员，向全员传达并留记录是机构自己的事。这条义务的转化链四步：派人去听监管培训（免费，第 1 章那五场）→ 回来内化成机构培训材料 → 全员传达 → 记录留痕。

培训记录四要素：时间、内容、参加人、考核方式。这页纸的双重身份要讲给团队听：平时是管理台账，迎检时是合规证据——10.4 节反推过，监管反复教的位置就是检查常看的位置，而「机构有没有把自己的培训做实」正是汕头口径点名的要求。AI 在培训上的位置：把监管培训的公开材料整理成内部课件框架、按检查要点生成考核题库初稿——材料整理归 AI，讲授与考核归人。

投入产出算一笔。**以下全部是假设参数**：十人机构，每季度一次全员合规内训 1 小时，年投入约 40 人时；综合时薪 80 元计，年成本约 3200 元。对照第 8 章算过的违规期望损失（假设参数下 3.6 万元/年量级），培训是合规动作里单价最低的一档。翻转参数：如果培训只做不记——讲完没有四要素记录，迎检时举证不能——这 3200 元等于白花，培训在合规意义上没有发生。**记录是培训的完成态，讲完没记，等于没做。**

什么情形下不灵：培训解决「不知道」，解决不了「不执行」——考核全过的人照样可能图省事跳过发布前检查。执行层的防松靠 10.5 的复查机制与 12.1 的定稿权，培训只是底线教育的第一层。

12.3 数字化人才：缺口 8 万的行价，内培比外招现实

行业报告口径（2025 口腔行业人才报告）：数字化义齿设计岗位需求年增 35%，数字化技能人才缺口 8 万。对机构的含义不必等报告解读——**会用数字化工具的人在市场上越来越抢手、越来越贵，等招聘市场给你送人，不如自己在岗位上养人。**

外招与内培的账，用算例过一遍。**以下全部是假设参数**：外招一名熟练使用数字化工具的运营，熟练者相对普通运营的薪资溢价按 30% 估，若普通运营月薪 8000 元，溢价即 2400 元/月、约 2.9 万元/年，且到岗后还要花三个月熟悉机构业务（隐性成本）。内培的成本：全员提示词公共课 8 小时（第 2 章内容）+ 岗位进阶课 16 小时，讲师用内部骨干，工时与学员工时合计按 24 人时 × 综合时薪 100 元计约 2400 元——一次性投入，技能留在机构里。翻转参数：如果机构只有一两个岗位需要深度数字化技能、且业务马上要用，外

招的即战力优势压倒内培的省钱优势——**岗位数量决定这道账站哪边：单点急需外招，多岗普及内培；连锁机构的正确答案是两条腿，总部养讲师、各店出学员。**

培养路径三步：公共课全员过提示词关（第 2 章）；运营岗加内容与数据课（第 4-6 章），咨询岗加合规话术课（第 7 章），合规岗加迎检与台账课（第 8-10 章）；对连锁机构，与开设口腔医学、医学美容技术专业的高职院校合作是储备通道——实习生按机构流程培养，毕业即上手。

什么情形下不灵：内培的前提是机构有人能当讲师——自己都没把第 2 章四要素用顺的机构，先花一个月把骨干练出来，再谈培训体系，顺序不能跳。

12.4 机构级风险检查清单：全书风险收进一张表

全书的合规动作收拢成一张机构级检查清单。五类风险，每类给检查动作、频次、责任人——这张表是第 8、9、10 章清单的总目录，贴墙用：

风险类	检查动作	频次	责任人	出处
广告	发布前检查清单六项；审查证明台账更新	每篇发布前；台账每月	运营+医生	第 8 章
药械	购验存用记录核对；效期与不良事件台账	每笔必记；台账每月	质控+库房	第 9 章
资质与迎检	四查自查底稿；五类档案完整性	每季度	质控负责人	第 10 章
隐私与 AI 失实	患者信息授权核查；AI 输出数字与引用溯源	每篇发布前；每月抽查	运营+医生	第 2、8 章
财税	发票与纳税口径对照（《增值税法》2026 年施行，第 1 章第四条线，具体条文以法规原文为准）	每季度	机构负责人	第 1 章

清单的使用方式三种：季度自查用全表（10.5 节拍）；日常发布只用广告子表；新人入职配套培训四要素（12.2 节）。三类风险里「隐私与 AI 失实」是本书独有的提醒——患者信息授权是医疗行业的固有红线，AI 失实是 AI 时代的增量风险，两样都不在传统检查清单里，自己加上。

什么情形下不灵：清单是风险下限的保证，不是能力上限——它保证机构不踩明坑，不保证机构抢到先机。清单之外的增长动作（第 4-7 章）照样要有人推，别让「合规岗」把整家机构的议程占满。

12.5 长跑：合规是 AI 增长复利的前提

收口把全书的逻辑合上。AI 是放大器：放大产能，也放大错误——一个提示词错误复制二十篇，是二十倍的风险敞口。第 8 章的发布前检查、第 7 章的不接手清单、第 10 章的季度自查，本质都是给放大器装刹车。刹车不影响速度的说法要修正：刹车决定的是这台车敢不敢开快——**合规流程扎实的机构，才敢把 AI 产能开到上限**。

50% 抽查密度下，行业在经历一轮存量出清：合规不达标的机构在被检查、整改、处罚消耗，达标的机构拿到的是相对优势的扩大。这不需要什么宏大判断，只是第 1 章那组数字的另一种读法——检查是确定性事件，达标是确定性能力，两个确定性相除，剩给达标者的就是份额。

全书的立场，收尾再复述一遍：**AI 管产能和速度，判断与签字始终在人**。效果承诺、价格承诺、风险告知，这三样永远是人的落款；科普的医学表述、案例的真实性、资质的每一行字，永远是人的责任。增长线（第 4-7 章）挣的钱，要经得起合规线（第 8-10 章）的检查，才算真挣到。

什么情形下不灵：这套「合规即竞争力」的逻辑有一个前提——机构还在乎长期经营。只想快进快出的经营者，理性选择本来就是踩线；本书的全部方法对这类读者没有意义，也不必说服他们。

动手练习

把组织能力落成三张表：

1. 用 AI 生成本机构的岗位分工表初稿（三岗位 × 职责 × 提示词库分区 × 定稿权边界，骨架按 12.1 的表），开会逐行确认，落责任人姓名——一人多岗的，把三顶帽子的使用场景写清楚。
2. 按培训四要素给机构排一份季度内训计划：公共课一轮、岗位课各一轮，讲师人选落人；把今年当地监管培训的场次排进「派人去听」的日历。
3. 把 12.4 的机构级检查清单打印上墙，五类风险的频次列写成日历提醒（AI 或人工均可），第一个月的检查动作本周就跑一遍——清单的第一次执行比清单本身重要。

思考题

1. 「讲完没记，等于没做」——你机构上一次内部培训是什么时候？四要素记录在吗？如果不在，这一次培训在合规意义上存在过吗？
2. 数字化人才缺口 8 万的行价在涨。按 12.3 的算例代入你机构的岗位数量：外招和内培，你站在账的哪一边？如果讲师人选到现在还没定，缺的是人还是机制？
3. 「合规流程扎实的机构，才敢把 AI 产能开到上限」——对照你机构现状：现在的 AI 使用规模，是被产能限制住了，还是被合规底气的不足限制住了？如果是后者，第 8-10 章里哪一关先补？

配图需求清单 （工作稿附注，出版时移除）

图号	类型	内容说明	来源建议
图 12-1	组织图	三岗位 AI 分工与提示词库三区对应，标注两个跨岗交接点	自绘
图 12-2	流程图	监管培训 → 机构内化 → 全员传达 → 记录留痕的内训转化链，标注培训记录四要素	自绘
图 12-3	算例图	外招 vs 内培算例：单点急需/多岗普及两档的结论对比，标注「假设参数」	自绘
图 12-4	清单图	机构级风险检查清单：广告/药械/资质/隐私与 AI 失实/财税五类，检查动作×频次×责任人	自绘

附录

附录 A 高频提示词索引

全书正文可直接复制的提示词按章索引如下（用途为该提示词所在位置上方文字的摘录；页码以正文为准）。

- 第 1 章 · 把下面这条提示词原样发过去：
- 第 2 章 · 对策：涉政策的活，把材料喂给它。比如：
- 第 2 章 · 看一个完整示例：
- 第 2 章 · 再给一个咨询场景的示例，展示「背景」怎么喂：
- 第 2 章 · 新建对话，把下面骨架补完整后发送：
- 第 3 章 · 打开大模型对话，发送（按你机构情况填空）：
- 第 4 章 · 落地动作是建一张「高频问题库」共享文档，三列：问题原文、被问次数、记录渠道（线上咨询/面诊/术后随访）。
- 第 4 章 · 初稿质量的分水岭不在「AI 好不好」，在提示词的「背景」和「要求」两栏喂了什么。第 2 章的四要素骨架在
- 第 5 章 · 检测的提示词骨架，可直接抄用：
- 第 6 章 · 合规回差评。 差评回复是公开内容，每一条都可能被潜在客户和 AI 读到，回复质量按对外内容的标准管。AI
- 第 7 章 · 提示词骨架沿用第 2 章，「背景」栏喂客户来源——从科普文章进来的客户和从团购进来的客户，开场的关注点不
- 第 7 章 · 异议处理的提示词把红线直接写进要求栏：
- 第 8 章 · AI 自查的用法：把成稿贴进去，让 AI 按四分类逐句标红，人复核标红结果并通读全文。提示词：
- 第 9 章 · AI 辅助的做法：用 AI 核对记录链的完整性——把台账数据贴给它，让它查断链和缺字段：
- 第 10 章 · AI 在归档环节的用法，一条提示词就能起步：
- 第 11 章 · 口述素材的转写整理提示词：

附录 B 本书出现的工具与平台

正文提到过的通用工具/平台，按拼音与出现顺序整理；版本与界面以官方最新为准。

豆包

参考文献与资料来源

> 检索日期：2026-11-02（初版 1-3 章）；2026-11-03 全书 12 章完成，来源清单复核无新增外部来源（第 4-12 章的行业数据仍全部出自下列条目，机构自测数字均已在正文标注「假设参数」）。全书行业数据与文件引用的来源按四类分列；调研底本为《行业调研卡 #87：消费医疗（医美口腔）》（检索日期 2026-11-01）。卡中标注「待验证」的条目照实转注，正文已注明。

一、政策与监管文件

1. 《2026 年国家随机监督抽查计划》（国疾控综监督二函〔2026〕63 号），国家疾控局、国家卫健委、国家中医药局，2026-03-19。要点：50% 医疗美容机构、20% 内设医美科室的医疗机构纳入年度抽查；口腔医疗机构列入医疗卫生抽查对象。 https://www.nhc.gov.cn/ylyjs/gzdt/202604/e4d18f523dbd478db9db249e88de3a54.shtml
2. 口腔种植体系统集采接续采购启动（「稳临床、保质量、反内卷、防围标」，竞价改公开询价），国家医保局（四川牵头），2026-09-28。报道来源：经济观察报。数据：首轮集采单颗种植牙均价约 1.5 万→7000 元、近 1.8 万家机构参与其中民营约 1.4 万家（占 80%）；中选产品纳入省级重点监管目录、UDI 全程追溯。 https://m.toutiao.com/group/7690858934047654400/
3. 《医疗美容机构、医疗口腔诊所行政合规指导清单》，海口市营商环境建设局（卫健牵头），2026-07。要点：经营资质、人员资质（医美主诊医师条件：美容外科 6 年/美容牙科 5 年临床经历+培训合格）、广告宣传（未取得《医疗广告审查证明》发布即违法，虚假广告罚广告费 3-10 倍）、药械进货查验、价格公示。 https://zffwzx.haikou.gov.cn/hgzd/zdcjhgqd/ylzs/202607/t1534421.shtml
4. 口腔与医疗美容诊疗服务能力提升专项行动（「五个一」），诸暨市卫健局、市监局等，2026-07。要点：78 家机构负责人集中培训，61 起违法案例以案释法。专项行动：https://www.zhuji.gov.cn/col/col1229074101/art/2026/art_be00b5d2c5f348cd8ac99766973ac9f7.html 培训报道：https://mpa.zj.gov.cn/col/col1228989352/art/2026/art_19e8322092a34f4aab3e8038e8238e7a.html
5. 《医疗器械监督管理条例》（2024 修订）罚则口径：最高 5-20 倍货值罚款；医疗器械购验存用全链条自查与追溯记录（UDI）义务。（转引自调研卡考核面，执行以条例原文与当地监管口径为准）

6. 《医疗美容服务管理办法》主诊医师资质条件口径（执业医师注册 + 相关临床学科工作年限 + 医疗美容专业培训或进修合格）。（海口合规指导清单全文引用，见第 3 条）
7. 《增值税法》2026-01-01 施行，民营口腔财税合规进入强制阶段。（行业专栏解读口径：https://c.m.163.com/news/a/KSO1IMVE0556L9J1.html ，具体条文以法规原文为准，待验证）

二、政府采购与监管活动公开信息

1. 潜江市医美机构约谈暨合规培训会（免费，70 余人），潜江市市监局，2026-10-29。内容：医美药械化合规专题培训——进货查验、索证索票、以案释法。http://mpa.hubei.gov.cn/bmdt/szdtnew/202610/t20261030_6045692.shtml
2. 汕头市医疗美容机构医疗器械质量安全法律法规培训会（免费，100 余人），汕头市市监局，2026-09。内容：2026 医美诊所医疗器械使用安全专项整治配套培训——采购验收/贮存/使用登记/不良事件监测；要求「全员内部传达+培训记录」。https://www.sohu.com/a/1076260017_121106875
3. 深圳宝安区医美机构合规培训（免费），宝安区市监局 + 区妇幼保健院（「医美科普合规基地」），2026-01-16。内容：合规经营/生物材料安全/注射技术规范/并发症应急处置实操。https://www.baoan.gov.cn/xxgk/xwzx/tpxw/content/post_12610497.html
4. 福鼎市行业告诫会 + 合规培训（51 家机构负责人参会），行业协会承接，2026-08。 http://www.fuding.gov.cn/bmzfxxgk/scjdglj/zfxxgkml/qtyzdgkdzf/202608/t20260824_2477482.htm
5. 说明：消费医疗行业政采钱面整体较弱——监管培训由政府组织免费开展，无公开大额政采中标记录；本书钱面结论（合规刚需+企业侧付费）即基于此事实与行业付费逻辑。

三、行业资料与报告

1. 医美获客成本口径：医美行业平均获客成本突破 3000 元/人；GEO 被称「2026 最大红利：技术布局后流量免费」。（医美美业 GEO/AI 获客白皮书口径）https://www.pandawm.com/医美美业 geo/3386.html
2. 口腔人才面：数字化义齿设计岗位需求年增 35%、数字化技能人才缺口 8 万（2025 口腔行业人才报告口径）；大连口腔义齿学校等校企合作培养，2026。http://www.100ec.cn/brand/2265152.html
3. 竞品书目：《口腔门诊全维管理》（董天宇，中华工商联合出版社，2025-08，ISBN 9787515843773）；《口腔医疗市场拓展（第 2 版）》（李刚，人民卫生出版社，2020-01）。竞争面结论：「AI+消费医疗获客与合规」角度两个细分均未命中书目。

4. 行业 SaaS 工具生态：领健 e 看牙（口腔医美 SaaS，含 AI 病历/AI 影像分析）、ABC 诊所管家（同类）。（调研卡竞争面提及，作为工具生态事实引用，本书不构成推荐背书）

四、课件与改编素材

1. 《AI 大模型进阶课》：与 AI 更好交流的提示词方法——改编为本书第 2 章四要素骨架与机构场景示例。
2. 《AI 营销》课程：AI 获客、内容种草、私域 SCRM 方法——改编为本书第 4、6 章的通用方法底座，叠加医疗广告合规改造。
3. 说明：通用课件仅提供方法论框架，书中全部医疗场景示例（科普文案、咨询话术、自查清单、差评回复）为本书原创；行业数据一律不取自课件，只取自上述一至三节来源。



milulab.com/books/ai-consumer-medical/

milulab.com/books

摩豆智能　卢章　著

dearsuley@gmail.com

行业 AI 书系 · 迷鹿 MiLu